

康希诺 PCV13 疫苗社会化媒体聆听 研究报告

瑞思无限

2026 年 2 月

目 录

一、研究设计	3
(一) 研究目标	3
(二) 数据采集规则	3
(三) 研究内容	4
二、目标人群画像及需求决策分析	5
(一) 总体情况说明	5
1、数据概述	5
2、目标人群画像特征	5
3、目标人群需求决策分析	8
(二) 冰山模型-隐性驱动 1：消费理念	9
1、消费理念三级标签情况	9
2、消费理念四级标签情况	11
(三) 冰山模型-隐性驱动 2：育儿理念	13
1、育儿理念三级标签情况	13
2、育儿理念四级标签情况	14
(四) 冰山模型-认知中介：儿童健康与疾病认知	15
1、儿童健康与疾病认知总体情况	15
2、儿童健康与疾病认知三级标签与 Z 时代妈妈	15
3、儿童健康与疾病认知三级标签与儿童周期	16
(五) 冰山模型-显性行为：自费疫苗认知及接受程度	16
1、自费疫苗认知及接受程度三级标签总体情况	16
2、自费疫苗认知及接受程度三级标签与 Z 时代妈妈	17
3、自费疫苗认知及接受程度三级标签与儿童周期	17
(六) 小结	18
三、用户决策旅程分析	20
(一) 用户决策旅程特征表现	20
1、总体情况	20
2、不同维度下的用户决策旅程表现	21
(二) 用户决策旅程“声量-态度”IPA 矩阵分析	23
(三) 认知了解阶段表现	24
1、认知了解三级标签情况	24
2、认知了解四级标签情况	26
(四) 信息搜集阶段表现	27
1、信息搜集三级标签情况	27
2、Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈	28
3、账号角色	28
(五) 对比决策阶段表现	29
1、对比决策三级标签情况	29
2、对比决策四级标签情况	30
(六) 推荐分享阶段表现	32
1、推荐分享三级标签情况	32
2、Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈	32
3、账号角色	33

(七) 小结.....	33
四、社媒分布分析	36
(一) 社媒平台分布情况	36
1、社媒平台总体情况	36
2、账号类型	37
3、主贴类型	39
(二) 内容主题	41
1、总体表现	41
2、“认知了解”标签的社媒分布	41
3、“信息搜集”标签的社媒分布	43
4、“对比决策”标签的社媒分布	43
5、“推荐分享”标签的社媒分布	45
(三) 社媒讨论空间分布	46
(四) 小结	48
五、本竞品口碑分析	50
(一) 企业品牌声量	50
1、企业品牌声量比例	50
2、企业品牌声量在不同媒介类型中的表现	51
3、企业品牌声量在不同主贴类型中的表现	52
4、企业品牌声量在不同账号类型中的表现	52
(二) 产品品牌声量	54
1、产品品牌声量比例	54
2、产品品牌声量在不同媒介类型中的表现	54
3、产品品牌声量在不同主贴类型中的表现	55
4、产品品牌声量在不同账号类型中的表现	56
(三) 企业品牌负面口碑分析	57
1、企业品牌负面口碑总体情况	57
2、辉瑞负面口碑分析	58
3、沃森负面口碑分析	60
4、民海负面口碑分析	63
5、康希诺负面口碑分析	65
(四) 产品负面口碑分析	67
1、沛儿 13 负面口碑分析	67
2、沃安欣负面口碑分析	67
3、维民菲宝负面口碑分析	68
(五) 小结	68
六、结论与建议	70
(一) 研究结论	70
(二) 对策建议	71
附录：“用户画像”+“用户决策旅程”标签体系（四级标签）	74

康希诺 PCV13 疫苗社会化媒体聆听研究报告

一、研究设计

（一）研究目标

综合利用互联网尤其是社媒数据，深度挖掘 PCV13 疫苗潜在接种者的人口属性、心理特征、消费行为及决策路径，为康希诺的产品上市、市场教育、品牌传播和渠道策略提供数据驱动的决策支持。

（二）数据采集规则

1、核心渠道关键词方案【数据 1 库】

（1）渠道选择：

- ◆ 主要渠道：小红书、抖音、微博、快手
- ◆ 辅助渠道：哔哩哔哩、知乎

（2）核心关键词：

- ◆ 单一关键词规则：13 价肺炎疫苗|13 价肺炎|肺炎疫苗|肺炎针|十三价肺炎|PCV13|肺炎十三价|肺炎 13 价。
- ◆ 组合关键词规则（括号为组合词）：（自费疫苗|二类疫苗|非免疫规划疫苗）+（宝宝|孩子|儿童|新手爸妈）

2、定制化人群关键词方案【数据 2 库】

（1）渠道选择：小红书

（2）核心关键词：Z 世代妈妈|Z 时代妈妈|#95 后带娃|#00 后带娃|（95 后|00 后）+带娃）

3、本竞品关键词方案【数据 3 库】

（1）渠道选择：全网

（2）核心关键词：

- 品牌：（沃森|玉溪沃森|云南沃森|辉瑞|民海|民海生物|北京民海|康希诺）+（肺炎|PCV）
- 产品：沃安欣|沛儿|沛儿 13|维民菲宝|优佩欣

4、数据周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 26 日

5、数据量说明：

根据设计的关键词方案，共采集到 208,711 条数据，其中有效数据为 152,326

条，剔除杂质后的分析数据为 134,924 条。（杂质数据如：非人类疫苗、非儿童疫苗等与分析目标无关的数据）

（三）研究内容

序号	二级标签	核心调研问题	调研目的
1	用户画像及需求	分析目标人群特征（社会经济状态+儿童接种周期，例如职业+收入+城市+儿童月龄+儿童接种情况）及对应接种需求	完成目标人群画像特征分析，包括年龄+地域+儿童周期及接种需求，了解 PCV13 疫苗社媒用户画像特征，结合决策旅程和讨论重点，构建用户画像知识图谱。
2	用户决策旅程	了解用户“认知-信息搜集-对比-决策”四个阶段决策旅程需求特点	按照四阶段决策旅程，设置内容标签体系，通过 AI 大模型划分社媒内容的用户决策旅程，构建客户决策漏斗模型，识别各阶段刚需痛点
3	社媒分布	分析不同平台的品类品牌声量，以及讨论核心主题内容	（1）对各平台内容声量比例和情感倾向进行分析，了解平台内容倾向。（2）深入分析各平台涉及肺炎疫苗账号角色，区别 KOL 和 KOC，完成媒体分析。（3）对社媒内容主题分析，了解不同平台不同用户旅程阶段下的主题标签表现，为肺炎疫苗消费场景描述、社媒长尾词创作提供策略方向
4	本竞品口碑	了解全网数据中本竞品声量及情感态度	（1）对本竞品品牌的内容声量比例和情感倾向进行分析，了解各品牌社媒表现。（2）各品牌负面口碑主题分析，了解品牌营销痛点。为后续品牌提升提供策略方向。

二、目标人群画像及需求决策分析

（一）总体情况说明

1、数据概述

目标人群画像主要使用数据库 1 库和 2 库的数据进行分析。

1 库：主要采集渠道为小红书，抖音，微博，快手，并以哔哩哔哩，知乎辅助。核心关键词确定为 13 价肺炎疫苗及其相近关键词

2 库：选择小红书为主要采集渠道，以 Z 时代妈妈及其相关词作为关键词

本部分“目标人群画像及需求分析”分析使用数据量为 97,706 条。

2、目标人群画像特征

（1）年龄特征

根据获取到目标人群数据，本报告把目标人群按照儿童周期划分以下阶段，如下表所示。

表 1 目标人群年龄分布情况（列百分比）

儿童周期	比例
孕期	5.60%
6 周-3 月龄	51.90%
7-11 月龄	11.90%
12-23 月龄	12.30%
2-5 岁	7.00%
头胎	42.20%
二胎	7.20%

结果表明，PCV13 疫苗讨论声量显著集中于 6 周-3 月龄接种窗口期与头胎家庭，二者活跃度远高于其他周期及二胎群体。该分布特征直接指向内容投放的关键靶点：**社媒内容应优先覆盖该窗口期家长的即时信息需求**，并针对性强化首次育儿家庭在接种程序、安全性等核心议题上的内容供给，以提升触达效率与用户共鸣。

（2）地域特征

根据社交媒体数据，报告分析了目标人群在 34 个省级行政区域（含省、自治区、直辖市、特别行政区）及境外地区的地域分布情况。结果如下表所示。点击可以观看该地图（[舆情热力图.html](#)），需注意的是，该地域分布为网络主贴舆论中涉及目标人群的地域分布，反映了某地域话题讨论声量程度。

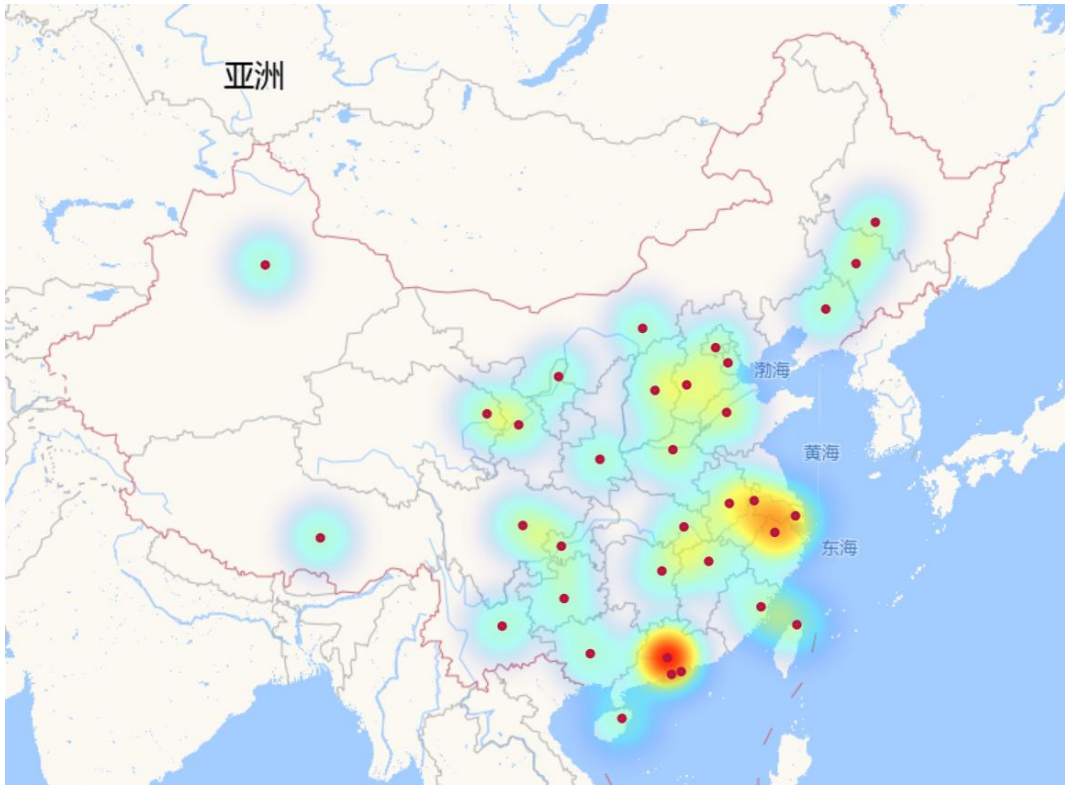


图 1 目标人群城市地域分布情况

在网络舆论环境中，PCV13 疫苗相关讨论呈现显著的地域集聚特征，主要集中在经济较发达、人口密集、互联网普及率较高的省级行政区域：广东省以 10.2% 的讨论量位居首位，显著高于其他地区，表明区域间信息关注度存在明显差异；浙江（7.0%）、山东（5.2%）、河南（5.1%）、四川（4.7%）、江苏（4.6%）、北京（3.8%）等地讨论量也处于较高水平，反映出东部及中部人口密集的省级行政区域在话题传播中的活跃度较高。

（3）社媒平台分布特征

根据社交媒体数据，本报告划分为以下 6 个平台，并与儿童周期进行交互分析。结果如图所示。

表 2 不同儿童周期下的社媒平台分布（多选，列百分比）

社媒平台	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
小红书	57.00%	64.20%	60.60%	53.80%	52.40%	74.90%	68.50%
微博	3.60%	4.70%	10.70%	16.80%	17.50%	7.00%	3.40%
抖音	37.10%	28.80%	25.40%	26.00%	27.00%	16.30%	25.70%
快手	2.40%	2.10%	3.20%	3.10%	2.80%	1.70%	2.30%
哔哩哔哩	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%
知乎	0.00%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%	0.20%	0.10%

小红书在 PCV13 疫苗讨论中占据主导地位，尤其在头胎家庭中表现尤为突

出，占比高达 74.90%，为各细分群体中最高。即使在 2-5 岁阶段（52.40%），小红书仍保持显著优势。这表明，首次育儿的家长高度依赖小红书来获取和分享疫苗相关信息。

微博和抖音构成第二梯队。抖音的整体讨论量高于微博，但在不同儿童周期中的表现有所分化：微博在 12-23 月龄（16.80%）和 2-5 岁（17.50%）阶段的占比显著上升，可能与该阶段家长更关注公共话题或政策信息相关；而抖音在孕期（37.10%）的讨论量较高，随后随孩子年龄增长略有下降，但仍稳定在 25%-28% 区间，显示出其在短视频科普传播中的持续影响力。

快手、哔哩哔哩和知乎的总体占比相对较低，表明这些平台在儿童疫苗议题上的影响力有限。

值得注意的是，二胎家庭在小红书的占比（68.50%）虽略低于头胎家庭，但仍显著高于其他平台。同时，抖音在二胎家庭中的占比（25.70%）明显高于头胎家庭（16.30%），暗示二胎家长可能更倾向于通过短视频渠道获取信息。

（4）涉及主贴类型特征

本报告将 PCV13 疫苗涉及的主贴分为七种类型，并与儿童周期进行交互分析。结果表明，在 PCV13 疫苗的主贴类型中，用户内容偏好呈现清晰的阶段性特征。结果如图所示。

表 3 不同儿童周期的主贴类型分布（多选，列百分比）

主贴类型	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
科普知识类	52.00%	44.80%	45.50%	50.30%	47.90%	47.80%	46.10%
个人体验分享	30.00%	32.00%	31.10%	30.70%	27.30%	30.70%	31.70%
咨询讨论类	34.30%	32.50%	34.40%	31.60%	34.00%	33.20%	35.30%
产品推荐类	33.80%	34.80%	37.20%	38.50%	38.10%	36.80%	35.80%
产品比较类	17.90%	18.20%	22.10%	22.30%	23.50%	20.20%	19.00%
政策宣传类	4.40%	4.50%	5.30%	4.90%	4.80%	4.70%	4.90%
广告宣传类	9.00%	8.60%	9.90%	8.80%	8.10%	8.40%	8.10%

科普知识类主导全周期（孕期 52.00%），是孕产期建立基础认知的核心内容；**产品推荐类**随月龄稳步上升，12 月龄后成为第二大类型（2-5 岁 38.10%），凸显接种窗口期对实操信息的迫切需求。**产品比较类**同步增长（2-5 岁 23.50%），反映高月龄阶段决策复杂性提升；**个人体验与咨询讨论类**稳定在 30% - 35%，二胎家庭咨询占比略高（35.30%）；**政策与广告类**占比均低于 10%，影响力有限。该分布为内容策略提供明确指引：孕产期聚焦权威科普，接种窗口期强化产品信

息与真实体验，高月龄阶段深化对比解析与决策辅助。

3、目标人群需求决策分析

（1）儿童健康决策冰山模型分析

在消费育儿理念及健康认知方面，本报告按照深层价值观到具体行为/产品选择的递进关系，构建“儿童健康决策冰山模型”，其中冰山水下为隐性驱动、冰山水上为显性表现，将儿童健康决策划分为三个层面：

- ◆ **水下深层：**包括消费理念、育儿理念，家长对“如何花钱”、“如何育儿”的看法，为隐性驱动层，对后续决策有潜在影响。
- ◆ **水中过渡层：**包括儿童健康认知、儿童疾病认知，家长对“什么是健康”、“哪些疾病需预防”的理解，是连接理念与具体医疗行为的桥梁，为认知中介层。
- ◆ **水上表层：**包括自费疫苗认知及接受程度，最外显的行为意向或实际决策，如是否接种 13 价肺炎球菌疫苗、是否在社媒平台咨询或推荐某疫苗，是理念最终落地的“产品触点”，为显性行为层。

根据冰山模型分层划分，各维度结果如下所示。

表 4 “儿童健康决策冰山模型”（二级标签）（多选）

冰山层级	特征	维度（二级标签）	列百分比
水下深层 （隐性驱动层）	消费价值观、身份认同	消费理念	35.00%
		育儿理念	66.20%
水中过渡层 （认知中介层）	健康素养、知识结构	儿童健康认知	58.10%
		儿童疾病认知	9.50%
水上表层 （显性行为层）	可观察的态度、选择、讨论	自费疫苗认知及接受程度	60.80%

相对而言，（1）“育儿理念”声量最高，占比达 66.20%，社交媒体成为儿童家长表达和讨论育儿价值观的重要平台，因此该类内容易于引发共鸣与互动，产生大量声量。（2）“自费疫苗认知及接受程度”占比 60.80%，仅次于“育儿理念”，自费疫苗并非国家免费提供，家长需自行判断是否接种，是否接种涉及成本、风险评估、医生建议、网络信息等多种因素，容易引发争议和讨论。（3）“儿童健康认知”占比 58.10%，位列第三，家长倾向于通过社媒平台获取实用建议，形成持续讨论。（4）“消费理念”占比 35.00%，属于中等水平，相比于育儿理念或健康决策，消费行为更具工具性，讨论深度和频率相对有限。（5）“儿童疾病认知”占比最低，仅 9.50%，是所有分类中声量最小的一项，表明家长较

少主动讨论具体疾病的医学知识（如病因、症状、治疗等），可能因专业性强或缺乏传播动力，家长更多依赖医生或权威机构信息，而非在社交媒体上自主讨论。

总体而言，儿童家长在社交媒体讨论更愿意谈论育儿价值观和可选择的医疗干预措施（如自费疫苗），对日常健康维护也有较高兴趣，但对具体疾病的专业认知则表现出较低参与度，可能是出于信息获取渠道的专业局限。

因此，在面向儿童家长的信息传播中，应结合育儿理念与实际决策场景，注重用通俗语言解释医学知识，才能有效提升健康科普的触达率与影响力。

（2）用户决策旅程分析

本报告将用户选择 PCV13 疫苗的决策旅程划分为以下 4 个决策阶段，并与儿童周期进行交互分析，如下表所示。

表 5 不同儿童周期下的用户决策旅程（多选，列百分比）

用户决策旅程	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
认知了解	76.00%	51.90%	49.40%	53.70%	56.40%	56.30%	38.90%
信息搜集	25.20%	21.70%	20.80%	18.30%	26.40%	24.30%	26.50%
对比决策	20.30%	32.60%	32.40%	34.80%	44.60%	34.60%	39.70%
推荐分享	44.60%	53.50%	61.20%	64.30%	61.90%	64.30%	76.10%

在 PCV13 疫苗的社交媒体讨论中，用户决策旅程呈现明显的阶段特征：**孕期**以“认知了解”为主导，而“推荐分享”在 6 周-3 月龄后持续高位，尤其在二胎家庭中表现最强。

孕期阶段，与“认知了解”的关联度最高（占比 76.00%），这是用户初步接触和了解肺炎疫苗的关键时期。进入婴儿出生后的各个阶段，“认知了解”的比例降至 51.90%至 56.40%，表明家长的基础认知已初步建立；“**信息搜集**”在整个 0-5 岁阶段保持相对平稳，其中 2-5 岁略升至 26.40%，显示出这一行为贯穿整个儿童周期；“**对比决策**”行为从 6 周-3 月龄开始逐渐上升，在 2-5 岁达到峰值（44.60%），反映出随着孩子年龄增长，家长对疫苗品牌和接种程序等细节的关注度提升，决策过程变得更加复杂；最突出的趋势体现在“**推荐分享**”：该行为在婴儿出生后持续处于高位，尤其在二胎家庭中表现最为显著，占比高达 76.10%，远超头胎家庭（64.30%）。这表明有育儿经验的家长更愿意在社媒平台主动传播疫苗相关信息，具备较强的口碑影响力。

（二）冰山模型-隐性驱动 1：消费理念

1、消费理念三级标签情况

（1）消费理念三级标签分布

本报告将消费理念进一步细分为三级主题标签，更深入了解目前人群的消费理念特点，如下表所示。

表 6 目标人群的消费理念三级标签表现（多选）

二级标签	三级标签	列百分比
消费理念	家庭经济状况	18.80%
	消费价值取向	72.80%
	品牌偏好	51.10%

注：“家庭经济状况”与“消费价值取向”数据来源于 1 库和 2 库，“品牌偏好”来源于 2 库

具体看，“消费价值取向”占比最高(72.80%)，“品牌偏好”次之(51.10%)，“家庭经济状况”占比较低(18.80%)。该分布反映在当前采集内容范围内，主贴讨论更集中于产品效用、投入产出比等价值评估维度及品牌信任议题，而对家庭经济状况的直接表述相对有限，符合社媒语境中消费讨论常嵌入具体场景（如疫苗选择、用品对比）的表达特征。

（2）消费理念三级标签与 Z 时代妈妈

本报告将消费理念与 Z 世代妈妈进行交互分析。结果表明，Z 世代妈妈消费理念呈现出“重价值、理性权衡”的特点，尤其在自费疫苗等高关注度健康产品上，其决策更依赖于信息透明度与科学依据，如下表所示。

表 7 Z 世代妈妈的消费理念三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	用户群体	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
家庭经济状况	18.40%	30.90%
消费价值取向	72.60%	80.40%
品牌偏好	51.60%	36.00%

具体看，Z 世代妈妈更突出“消费价值取向”，体现出对产品实际效用、性价比和长期健康收益的重视；其对“家庭经济状况”的讨论也相对更多，表明在消费决策中更明确地纳入经济能力考量，但并未弱化对价值本身的判断。

（3）消费理念三级标签与儿童周期

本报告将消费理念与不同儿童周期进行交互分析。结果表明，不同育儿阶段对产品价值与品牌的关注存在阶段性差异，如下表所示。

表 8 不同儿童周期的消费理念三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	儿童周期						
	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
家庭经济状况	24.10%	19.50%	27.60%	29.70%	27.50%	23.30%	23.10%
消费价值取向	79.20%	70.40%	82.50%	80.30%	82.60%	84.30%	73.50%
品牌偏好	30.70%	52.90%	30.00%	34.80%	38.40%	38.10%	51.90%

不同儿童周期中，“消费价值取向”始终占主导，尤以孕期和头胎家庭最为突出，体现育儿初期对疫苗效用与安全性的理性关注；“品牌偏好”在 6 周-3 月龄达峰后随年龄增长回落，反映接种窗口期依赖品牌信任，后期转向经验驱动；“家庭经济状况”整体占比较低，仅在 12-23 月龄略有上升，可能与加强针或补种带来的费用累积有关；整体来看，头胎家庭更注重价值评估，二胎家庭则更倾向依赖品牌经验或口碑。

2、消费理念四级标签情况

（1）Z 时代妈妈的消费理念四级标签表现

为进一步了解消费理念，本报告将三级标签消费理念进一步细分至四级标签，并与 Z 时代妈妈交互分析，其中，家庭经济状况和消费价值取向这两个三级标签的交互分析结果如下表所示。

表 9 Z 时代妈妈的消费理念四级标签表现（多选，列百分比）

二级标签	三级标签	四级标签	是否 Z 世代妈妈	
			非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
消费理念	家庭经济状况	宽裕稳定型	31.00%	36.70%
		收支平衡型	43.90%	35.20%
		预算紧缩型	29.90%	28.10%
	消费价值取向	价格驱动型	40.70%	43.50%
		品牌信赖型	14.80%	15.30%
		功能导向型	80.80%	81.70%

家庭经济状况：在社交媒体讨论中，Z 世代妈妈中“宽裕稳定型”占比略高于非 Z 世代妈妈（36.70% vs 31.00%），而“收支平衡型”和“预算紧缩型”占比相对较低，但从整体消费看，发现发帖人群消费策略上仍保持理性，多数仍处于“收支平衡”或“预算紧缩”状态；**消费价值取向：**在社交媒体讨论中，主贴均以“功能导向型”为主导，占比分别为 80.80%和 81.70%，表明无论是否为 Z 世代妈妈，其决策核心均为产品实际效用与健康收益。综合来看，尽管 Z 世代妈妈拥有较好的经济条件，但在育儿消费决策中依然保持理性，重视产品的实际效

用与经济效益。

此外，本报告将消费理念三级标签“品牌偏好”与 Z 时代妈妈做交互分析，结果如下表所示。

表 10 Z 时代妈妈的品牌偏好表现（多选，列百分比）

二级标签	三级标签	四级标签	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
消费理念	品牌偏好	国产	71.60%	63.40%
		进口	31.80%	37.40%

“国产”疫苗品牌在非 Z 世代妈妈中占比达 71.60%，而在 Z 世代妈妈中为 63.40%，该差距是表中唯一具有统计意义的代际分化点，说明 Z 世代妈妈虽仍以国产为主，但对进口品牌的接受度更高。“进口”疫苗在 Z 世代妈妈中的占比为 37.40%，高于非 Z 世代的 31.80%，体现出更强的品牌国际化视野。

（2）不同儿童周期的消费理念四级标签表现

将消费理念四级标签与儿童周期进行交互分析，如下表所示。

表 11 不同儿童周期的消费理念四级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	儿童周期						
		孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
家庭经济状况	宽裕稳定型	13.70%	32.40%	42.50%	52.60%	52.80%	39.30%	18.80%
	收支平衡型	64.70%	49.10%	40.80%	32.60%	38.70%	54.50%	51.30%
	预算紧缩型	21.60%	19.80%	18.30%	16.60%	12.30%	8.30%	32.50%
消费价值取向	价格驱动型	41.70%	40.10%	41.30%	47.10%	46.50%	48.60%	50.60%
	品牌信赖型	13.10%	18.60%	9.50%	10.10%	8.80%	12.10%	21.20%
	功能导向型	73.20%	76.20%	83.20%	83.70%	87.40%	77.80%	67.80%

用户关注焦点高度集中于疫苗的实际效用，经济与品牌因素处于次要位置。在各儿童周期中，用户的讨论焦点极度向“功能导向型”消费取向倾斜，其占比在 2-5 岁阶段高达 87.40%，远超“价格驱动型”和“品牌信赖型”。同时，“功能导向型”在头胎家庭（77.80%）显著高于二胎家庭（67.80%），表明首次育儿更聚焦疫苗的核心保护价值。

此外，本报告将消费理念三级标签“品牌偏好”与儿童周期交互分析，结果如下表所示。

表 12 不同儿童周期的品牌偏好表现（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	儿童周期						
		孕期	6周-3月龄	7-11月龄	12-23月龄	2-5岁	头胎	二胎
品牌偏好	国产	37.30%	46.20%	56.10%	59.80%	73.00%	52.70%	67.80%
	进口	65.70%	56.60%	47.00%	43.50%	29.60%	50.60%	37.20%

其中，“进口”疫苗在孕期占比达 65.70%，为各周期中最高，随后随孩子年龄增长持续下降，在 2-5 岁降至 29.60%，这一趋势表明家长在首次接种前更关注国际标准、技术来源等外显优势，倾向于通过进口产品建立信心。“国产”疫苗偏好从孕期的 37.30%稳步上升，至 2-5 岁达到 73.00%，成为唯一在后期显著超越进口的选项，说明随着接种过程推进，家长对国产疫苗的安全性、有效性及可及性的认知逐渐增强，形成稳定信任。值得注意的是，“国产”疫苗在二胎家庭中占比高于头胎占比，可能因已有育儿经验者经过对比国内外品牌，选择性价比更高的国产疫苗；“进口”在头胎中为 50.60%，略高于二胎的 37.20%，反映在社媒讨论中，初育家庭更信任国际标准、技术来源等外显优势。

（三）冰山模型-隐性驱动 2：育儿理念

1、育儿理念三级标签情况

（1）育儿理念三级标签分布

根据数据，本报告将社交媒体中涉及到的育儿理念划分为如下两类，如下表所示。

表 13 目标人群的育儿理念（多选）

二级标签	三级标签	列百分比
育儿理念	科学导向	74.10%
	风险导向	79.60%

用户育儿理念高度聚焦于风险规避，科学认知作为重要支撑。在社交媒体主贴中，“风险导向”占比为 79.60%，略高于“科学导向”的 74.10%，表明家长在 PCV13 疫苗决策中，首要驱动力是对疾病潜在危害、重症风险及健康影响的警惕，强调“防患于未然”；科学信息虽广泛存在，但更多服务于风险判断，而非独立驱动决策。

（2）育儿理念三级标签与 Z 时代妈妈

本报告将育儿理念与是否为 Z 时代妈妈进行交互分析，如下表所示。结果表明，Z 世代与非 Z 世代妈妈在育儿理念上存在结构性差异，社媒数据体现两类妈

妈在决策驱动力上呈现“Z世代重科学、非Z世代重风险”的分化特征。

表 14 Z世代妈妈的育儿理念三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
科学导向	73.70%	83.60%
风险导向	79.80%	72.40%

（3）育儿理念三级标签与儿童周期

本报告将育儿理念与不同儿童周期进行交互分析，如下表所示。结果表明，在不同儿童周期中的育儿理念呈现阶段性特征：孕期以“科学导向”为主导，二胎家庭则更受“风险导向”驱动。

表 15 不同儿童周期的育儿理念三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	儿童周期						
	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
科学导向	93.20%	86.70%	84.50%	88.80%	86.10%	90.00%	76.80%
风险导向	79.60%	78.20%	80.70%	79.20%	80.90%	85.50%	88.80%

“科学导向”在各儿童周期的主贴讨论中均显著高于“风险导向”，呈现出全面主导的态势。“风险导向”整体声量略低但稳定，在二胎家庭主贴中占比达 88.80%，显著高于其他细分场景。

2、育儿理念四级标签情况

（1）育儿理念四级标签与 Z 时代妈妈

Z世代妈妈在“科学育儿心理层面”和“风险认同”上的关注度高于非Z世代妈妈，而“科学育儿生理层面”和“风险厌恶”则低于非Z世代妈妈，反映出Z世代妈妈育儿理念呈现“重心理发展、强风险接受”特征。

表 16 科学导向、风险导向：是否 Z 时代妈妈（多选，列百分比）

二级标签	三级标签	四级标签	是否 Z 世代妈妈	
			非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
育儿理念	科学导向	科学育儿生理层面	98.30%	81.70%
		科学育儿心理层面	17.00%	26.20%
	风险导向	风险认同	92.10%	94.20%
		风险厌恶	5.50%	2.40%
		平常心看待	8.80%	9.10%

科学导向方面，Z世代妈妈“科学育儿心理层面”比例为 26.20%，高于非Z世代妈妈的 17.00%，这表明 Z 世代妈妈不仅关注疫苗的医学有效性，更重视接种对孩子整体成长、情绪稳定等心理维度的影响，体现出更全面、更具前瞻性的

科学育儿观。

风险导向方面，Z 世代妈妈“风险认同”比例高达 94.20%，但“风险厌恶”仅 2.40%。这表明 Z 世代妈妈普遍认可肺炎疾病的风险存在，却并不以焦虑或恐惧驱动决策，而是以理性接纳和主动防护的态度看待疫苗接种，凸显其理性均衡的风险认知。

（2）育儿理念四级标签与儿童周期

将科学导向的下钻标签与儿童周期交互分析发现，如下表所示。在儿童不同成长阶段中，“科学育儿生理层面”始终占据绝对主导地位，占比普遍超过 97%，而“科学育儿心理层面”则随儿童年龄增长显著下降，尤其在 2-5 岁降至 3.70%。

表 17 科学导向、风险导向：儿童周期（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	儿童周期						
		孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
科学导向	科学育儿生理层面	98.50%	97.90%	99.00%	99.50%	99.40%	98.80%	99.00%
	科学育儿心理层面	58.00%	38.10%	10.90%	12.70%	3.70%	27.20%	15.40%
风险导向	风险认同	98.20%	92.60%	91.50%	93.50%	94.30%	95.30%	91.30%
	风险厌恶	0.80%	3.30%	3.80%	3.70%	4.70%	1.80%	5.70%
	平常心看待	5.70%	12.10%	11.20%	7.50%	6.90%	9.80%	8.00%

儿童家长在育儿理念上的关注重心随儿童成长周期动态演变，从孕期至早期婴儿阶段以“科学育儿生理层面”和“风险认同”为主导，进入 2-5 岁后转向更成熟的风险评估与心理调适；而二胎家庭表现出更强的理性决策倾向，尤其在“风险厌恶”上显著高于头胎。

（四）冰山模型-认知中介：儿童健康与疾病认知

1、儿童健康与疾病认知总体情况

儿童健康与疾病认知划分为如下四级标签，如下表所示。

表 18 目标人群的儿童健康与疾病认知情况

二级标签	三级标签	四级标签	列百分比
儿童健康与疾病认知	儿童健康认知	长期健康规划意识	38.70%
		预防优于治疗观念	99.00%
	儿童疾病认知	疾病认知-肺炎	73.80%

可以看出，家长在儿童疫苗决策中普遍秉持“预防优于治疗”的核心理念，且对“肺炎”疾病的认知占据绝对主导地位，是影响接种行为的关键认知锚点。

2、儿童健康与疾病认知三级标签与 Z 时代妈妈

Z世代妈妈在“长期健康规划意识”上的占比（65.70%）显著高于非Z世代妈妈（38.10%），是两组间差异最突出的认知维度，表明其更倾向于将疫苗纳入系统性育儿规划。Z世代妈妈关于儿童肺炎认知比例高于非Z世代妈妈。

表 19 儿童健康与疾病认知：是否 Z 时代妈妈（多选，列百分比）

二级标签	三级标签	是否 Z 世代妈妈	
		非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
儿童健康认知	长期健康规划意识	38.10%	65.70%
	预防优于治疗观念	99.00%	94.60%
儿童疾病认知	疾病认知-肺炎	73.70%	76.00%

3、儿童健康与疾病认知三级标签与儿童周期

“预防优于治疗观念”在所有儿童周期中均保持 98%以上的高占比，是贯穿全生命周期的主导健康认知，而“长期健康规划意识”在 2-5 岁阶段达到 60.30%，为各周期最高，表明家长在孩子成长后期更倾向于将疫苗纳入系统性健康管理。“疾病认知-肺炎”在各阶段均占主导，属基础共识。

表 20 儿童健康与疾病认知：儿童周期（多选，列百分比）

二级标签	三级标签	儿童周期						
		孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
儿童健康认知	长期健康规划意识	54.50%	36.50%	45.30%	54.40%	60.30%	49.60%	54.30%
	预防优于治疗观念	98.80%	99.30%	99.60%	99.60%	99.40%	99.60%	99.10%
儿童疾病认知	疾病认知-肺炎	83.50%	77.20%	73.00%	71.30%	67.90%	76.10%	84.10%

（五）冰山模型-显性行为：自费疫苗认知及接受程度

1、自费疫苗认知及接受程度三级标签总体情况

将自费疫苗认知及接受程度划分为以下五种类型，如下表所示。

表 21 目标人群的自费疫苗认知及接受程度情况

二级标签	三级标签	计数	列数 %
自费疫苗认知及接受程度	科学决策型	10752	44.00%
	社媒驱动型	7139	29.20%
	价值权衡型	2164	8.80%
	便捷优先型	9829	40.20%
	焦虑观望型	4611	18.90%

在自费疫苗决策因素中，“科学决策型”和“便捷优先型”为两大主导类型，合计占比达 84.20%，表明家长在选择 PCV 时既重视医学依据，也高度关注接种流程的便利性；“社媒驱动型”占 29.20%，显示社交媒体影响力显著；而“价值

权衡型”与“焦虑观望型”占比相对较低，说明价格敏感与犹豫心态并非主流。

2、自费疫苗认知及接受程度三级标签与 Z 时代妈妈

本报告将自费疫苗认知及接受程度与是否为 Z 时代妈妈进行交互分析。结果表明，Z 世代妈妈的 PCV 接受行为由“科学+社交”双重驱动。结果如图所示。

表 22 Z 世代妈妈的自费疫苗认知及接受程度表现（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
科学决策型	43.60%	60.30%
社媒驱动型	28.90%	41.90%
价值权衡型	8.80%	11.10%
便捷优先型	40.40%	30.50%
焦虑观望型	19.20%	5.80%

“科学决策型”在 Z 世代妈妈中占比为 60.30%，显著高于非 Z 世代的 43.60%，这一差距是表中最大且最具策略意义的代际差异，说明 Z 世代妈妈更倾向于主动获取医学知识、参考临床数据或咨询专业意见，决策过程更具系统性和自主性。

“社媒驱动型”在 Z 世代妈妈中达 41.90%，远超非 Z 世代的 28.90%，表明其更易受真实用户分享、KOL 推荐和社群讨论影响。该标签与“科学决策型”共同构成其决策闭环——先通过专业内容建立认知，再通过社交验证形成行动意愿。

“便捷优先型”在 Z 世代妈妈中为 30.50%，低于非 Z 世代的 40.40%，说明其对接种流程的便利性关注度相对较低；“焦虑观望型”仅占 5.80%，远低于非 Z 世代的 19.20%，反映其决策更果断，不确定性容忍度更高。

3、自费疫苗认知及接受程度三级标签与儿童周期

将自费疫苗认知及接受程度与儿童周期进行交互分析发现，“科学决策型”在孕期和 2-5 岁形成双高峰，而“便捷优先型”仅在孕期显著高于其他阶段，表明孕产期是科学认知与接种便利性双重关注的集中窗口。

表 23 不同儿童周期的自费疫苗认知及接受程度比例（多选，列百分比）

三级标签	儿童周期						
	孕期	6 周-3 月龄	7-11 月龄	12-23 月龄	2-5 岁	头胎	二胎
科学决策型	67.40%	42.80%	50.80%	58.70%	63.50%	59.10%	56.10%
社媒驱动型	28.10%	29.20%	30.20%	20.70%	25.00%	26.10%	35.30%
价值权衡型	9.80%	6.10%	8.30%	9.70%	11.10%	9.90%	13.70%
便捷优先型	56.50%	47.80%	39.50%	47.40%	45.50%	48.00%	42.20%
焦虑观望型	2.30%	19.30%	20.10%	12.30%	13.70%	11.80%	13.40%

“科学决策型”在孕期达 67.40%，为全周期最高，**凸显孕产期是家长主动建立疫苗科学认知的关键阶段**；该比例在婴儿出生后下降，但在 2-5 岁回升至 63.50%，可能与加强针或补种决策相关。“便捷优先型”在孕期为 56.50%，明显高于 6 周-3 月龄及之后各阶段（均≤48%），说明只有在孕产期，流程便利性被显著强调。

（六）小结

基于对“自费疫苗”、“PCV13 疫苗”、“Z 世代妈妈”等关键词在主流社媒平台的主贴数据挖掘，本章从人群结构、内容偏好、认知逻辑与决策行为等方面系统刻画了当前 PCV13 疫苗潜在用户的画像特征与需求动因。主要研究发现包括以下方面。

1、用户结构高度聚焦：头胎家庭与早期接种窗口构成核心沟通场景

数据显示，围绕上述关键词的讨论声量显著集中于头胎家庭（42.2%）与 6 周-3 月龄婴儿阶段（51.9%），二者叠加形成高密度信息交互场域。地域上，广东、浙江、山东等经济发达、人口基数大的省份贡献主要声量；平台分布则呈现“小红书主导、抖音辅助、微博补充”的格局，其中小红书在头胎群体中的渗透率高达 74.9%，是家长获取疫苗信息、分享接种经验的核心阵地。

2、国产与进口疫苗选择呈现周期性分化，Z 世代更趋理性权衡

在疫苗类型偏好上，Z 世代妈妈以国产疫苗为主导（63.4%），但不同儿童周期与代际群体存在显著差异。

（1）**按儿童周期看**：孕期及 6 周-3 月龄阶段，家长对进口疫苗关注度最高（分别达 65.7%和 56.6%），此阶段信息搜集密集，对品牌安全性、国际使用经验高度敏感；随着孩子进入 7 月龄以上，国产疫苗占比稳步上升，在 2-5 岁阶段达 68.9%，反映家长在经历实际接种或受社区/医院推荐影响后，对国产产品的接受度提升。

（2）**按代际群体看**：Z 世代妈妈对进口疫苗的接受度（37.4%）略高于非 Z 世代（31.8%），但其选择并非盲目倾向“洋品牌”，而是基于对有效性数据、接种程序便利性及价格性价比的综合评估；同时，Z 世代“功能导向型”消费理念突出（80.4%），更关注疫苗是否覆盖本地流行血清型、是否纳入免疫规划参考体系等实际指标，而非单纯依赖产地标签。值得注意的是，Z 世代妈妈在疫苗

决策中表现出鲜明的理性化、科学化育儿新范式：

- ◆ 其“科学决策型”倾向（60.3%）显著高于非 Z 世代（42.1%）；
- ◆ “焦虑观望型”比例仅 5.8%，远低于非 Z 世代的 19.2%；
- ◆ 更重视“科学育儿心理层面”（26.2% vs 17.0%），体现出在保障健康的同时兼顾亲子关系与情绪价值的整体育儿观。

因此，面向 Z 世代妈妈，应避免简单强调“国产替代”或“进口高端”，而应提供透明、可比、基于本地流行病学的数据支撑（如康希诺 PCV13 对国内优势血清型的覆盖能力、真实世界保护效力）。可设计“国产 vs 进口对比指南”类内容，突出国产疫苗在供应稳定性、接种可及性及政策支持方面的优势，契合其理性权衡的决策逻辑。

3、认知与决策呈“冰山式”分层：理念驱动行为，但疾病知识薄弱

家长对 PCV 相关议题的讨论呈现出清晰的“冰山结构”：水下深层以**育儿理念**（66.2%）和**消费理念**（四级标签“功能导向型”比例普遍超 70%）为价值根基；水中层为**儿童健康认知**（58.1%）；而水上显性行为则体现为**自费疫苗接受度**（60.8%）。值得注意的是，“**儿童疾病认知**”声量最低（仅 9.5%），表明家长虽高度关注疫苗防护效果，却极少主动探讨肺炎等疾病的流行病学特征或临床危害，存在“重预防、轻病因”的认知回避特点。

与此同时，用户决策旅程呈现阶段性演进：孕期以“认知了解”为主（76.0%），出生后迅速转向“推荐分享”（二胎家庭达 76.1%），2-5 岁阶段则进入“对比决策”高峰（44.6%）。这说明家长不仅自身经历完整决策链，更在后期成为影响他人的关键节点，尤其二胎家庭具备更强的经验输出意愿与社群影响力。

三、用户决策旅程分析

本部分旨在分析普通用户在社交媒体上关于 PCV13 疫苗（含自费疫苗）讨论过程中反映的决策旅程，主要聚焦于数据库 1 分析。为剔除机构或企业数据，本报告对账号角色进行划分，具体包括 10 类：

- ◆ Z1. 官方政务账号：是指由政府部门或政务机构运营的账号，如疾控中心、卫健委、卫生局、政府、政务、公安、法院、检察院、行政、XX 局、XX 所、大队、医院、学校等。
- ◆ Z2. 机构/企业账号：是指由企业或机构运营的官方账号，如母婴品牌、疫苗生产商、奶粉品牌、尿不湿品牌、某集团、某企业、某公司、研究院、研究所等。
- ◆ Z3. 医生账号：是指由医院、诊所、执业医师或医疗专业人士运营的账号，提供医疗内容。
- ◆ Z4. 媒体账号：是指由媒体机构运营的账号，如新闻、日报、电视、TV、媒体、广播、电台、报刊、杂志、出版、卫视等。
- ◆ Z5. 专业人士账号：是指由医疗健康领域专业人士（非医生）运营的账号，如营养师、哺乳师、催奶师、育婴师、月嫂、育儿师、护理师、健康管理师、保健、康复、理疗等。
- ◆ Z6. KOL 账号：是指粉丝数 ≥ 10000 的具有高影响力账号。
- ◆ Z7. 普通账号：是指粉丝数在 1000 到 10000 之间的账号。
- ◆ Z8. 素人账号：是指粉丝数 < 1000 的账号。
- ◆ Z9. 宝妈账号：是指在普通账号和素人账号中，作者名能够体现出来账号身份为妈妈、母亲的账号，如怡宝麻麻、职场辣妈 Yuki、小丫妈咪等。
- ◆ Z10. 宝爸账号：是指在普通账号和素人账号中，作者名能够体现出来账号身份为爸爸、父亲的账号，如琦玉爸爸、菜菜籽老公带娃记、崽崽耙比等。

数据库 1 中有效数据共计 68,924 条，剔除 Z1 至 Z5 类账号（官方政务账号、机构/企业账号、医生账号、媒体账号、专业人士账号）数据后，最终得到 65,182 条用户 UGC 数据用于本章节分析。

（一）用户决策旅程特征表现

1、总体情况

分析显示，社媒讨论在用户决策旅程中的分布不均，正由传统媒体的“漏斗模型”转变为社媒时代的“沙漏模型”。用户在“认知了解”与“推荐分享”阶段的参与度显著更高（均超 50%），而“信息搜集”阶段比例偏低（仅 15.80%），反映出用户对 PCV13 疫苗的“知识获取与结果分享”的高关注度，“对比决策”环节则呈现中间水平（27.20%）的理性选择特征。

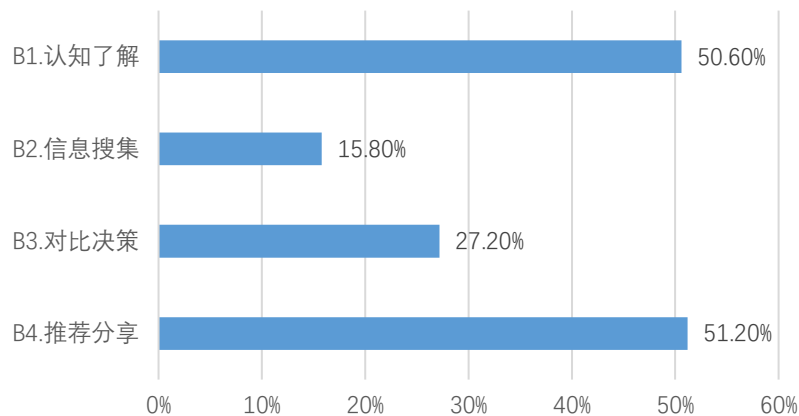


图 2 用户决策旅程阶段比例（多选）

注：该分析结果来自数据库 1

2、不同维度下的用户决策旅程表现

（1）Z 世代妈妈维度

分析显示，非 Z 世代妈妈与 Z 世代妈妈在用户决策旅程中呈现显著不同的行为分布特征：非 Z 世代妈妈更聚焦“认知了解”与“推荐分享”阶段，Z 世代妈妈则在“信息搜集”“对比决策”阶段比例提升明显，且“推荐分享”阶段比例极高，表明 Z 世代妈妈更乐于主动分享育儿经验，消费者决策旅程正从“被动接受信息”转向“社交化参与决策”。

表 24 不同妈妈特征下用户决策旅程比例（多选，列百分比）

二级标签	妈妈特征	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
认知了解	50.60%	49.50%
信息搜集	15.50%	32.10%
对比决策	26.90%	47.10%
推荐分享	50.70%	80.10%

（2）账号角色维度

分析显示，各账号角色的用户决策旅程呈现“认知了解”与“推荐分享”阶段比例高、“信息搜集”阶段比例低的显著特征，如下表所示。

表 25 不同账号角色下用户决策旅程比例（多选，列百分比）

二级标签	UGC 账号角色				
	KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
认知了解	56.20%	62.30%	49.10%	57.10%	52.60%
信息搜集	12.40%	8.80%	16.60%	12.90%	15.40%
对比决策	23.40%	19.10%	28.30%	22.10%	22.90%
推荐分享	49.00%	44.00%	52.10%	50.80%	51.50%

具体看，普通用户是贯穿疫苗决策全旅程的主力内容生产者，尤其在“认知了解”和“推荐分享”阶段占绝对主导；KOL 在“对比决策”阶段作用突出；而“信息搜集”阶段各账号类型参与度均较低，未出现某一角色显著领先的情况。

（3）企业品牌维度

分析显示，用户对于不同企业品牌，在不同决策旅程阶段的关注度存在差异。

表 26 用户决策旅程：企业品牌声量（多选，列百分比）

二级标签	企业品牌声量			
	康希诺	沃森	辉瑞	民海
认知了解	37.60%	45.60%	43.00%	42.70%
信息搜集	25.90%	25.50%	30.00%	27.70%
对比决策	49.40%	58.70%	66.70%	65.10%
推荐分享	57.40%	67.80%	63.30%	64.40%

综合来看，各企业品牌在用户决策旅程中呈现差异化声量特征。**康希诺**前期认知触达不足，但凭借良好的产品体验在推荐分享阶段实现口碑跃升；**沃森**则展现出全链路声量优势，从初期高曝光到后期高推荐，用户认可度与传播意愿持续保持高强度声量领先；**辉瑞**依托品牌势能在对比决策阶段表现突出，但推荐分享环节声量有所回落；民海虽未在早期广泛曝光，却在决策与推荐阶段保持声量强劲表现。

（4）产品品牌维度

分析显示，用户对于不同企业品牌，在不同决策旅程阶段的关注度存在差异。

表 27 用户决策旅程：产品品牌声量（多选，列百分比）

二级标签	产品品牌声量			
	优佩欣	沃安欣	沛儿 13	维民菲宝
认知了解	60.00%	47.70%	51.10%	46.30%
信息搜集	20.00%	19.90%	27.80%	23.00%
对比决策	55.00%	58.20%	70.60%	68.40%
推荐分享	35.00%	67.70%	60.10%	62.10%

综合各品牌在用户决策旅程中的声量表现可见，不同产品所处生命周期阶段深刻影响其传播路径。**优佩欣**作为新上市产品，凭借较强的初期曝光在“认知了解”阶段实现高效触达，但用户后续主动深入探索意愿明显不足（信息搜集阶段声量骤降至 20%），虽在对比决策阶段短暂回升，推荐分享意愿仍显疲软（35.00%），反映出新品在完成初步认知后，尚未有效建立持续的信息信任与体验闭环；相比之下，**沃安欣**与**维民菲宝**虽前期声量平缓，但在决策后期及推荐阶段实现显著跃升，体现出声量优势；而**沛儿 13** 则已形成“主动搜寻—高决策意愿—积极分享”的成熟正向循环，用户自传播效应突出。整体来看，新上市产品需在突破初始认知后，重点强化信息深度供给与真实体验沉淀，以打通从“被看见”到“被选择”再到“被推荐”的完整链路。

（二）用户决策旅程“声量-态度”IPA 矩阵分析

通过社媒数据分析，得到用户决策旅程二级标签的社媒声量和情感分析，如下表所示。

表 28 用户旅程二级标签“声量-情感”数据结果

用户旅程	社媒声量	PCV13 情感得分 正面=1，中性=0，负面=-1
B1.认知了解	50.60%	0.27
B2.信息搜集	15.80%	0.22
B3.对比决策	27.20%	0.29
B4.推荐分享	51.20%	0.32

为便于分析比较，将社媒声量和情感得分进行标准化处理，计算 Z 值（Z 值为 0 时是该指标均值，大于 0 表明该指标大于均值，小于 0 表明该指标小于均值），并将声量 Z 值为横坐标（投入），情感得分 Z 值为纵坐标（产出），得到用户旅程二级标签的“声量-情感”IPA 矩阵，如下图所示。

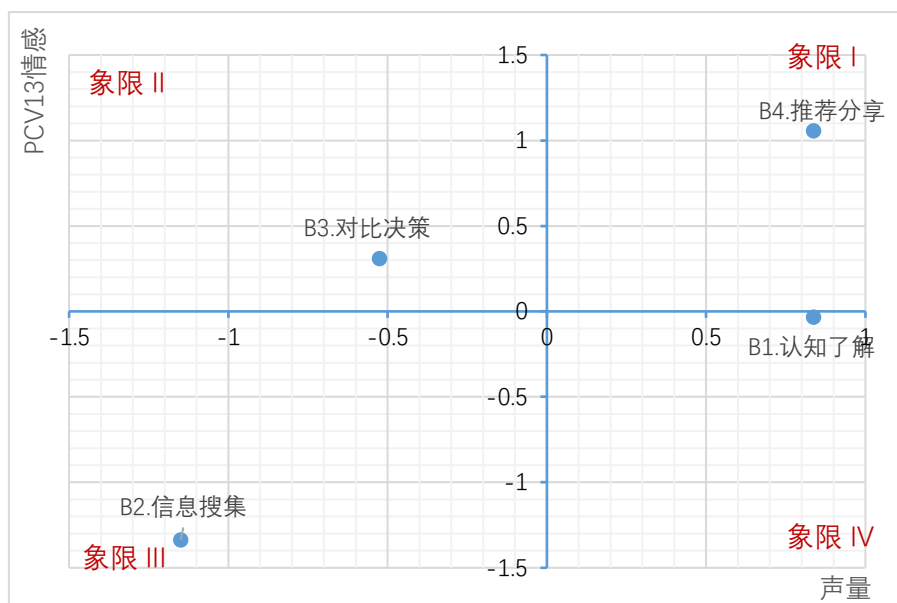


图 3 用户决策旅程二级标签 IPA 矩阵分析
注：该分析结果来自数据库 1

根据上面的 IPA 矩阵分析结果，将用户旅程二级标签作为内容主题，可以看出，当前用户旅程中，“推荐分享”处于优势区，体现高参与度与积极评价；“对比决策”为潜在机会区，虽讨论较少但体验极佳，具备转化潜力；而“认知了解”位于改进区，需针对性优化以提升整体传播效能。

表 29 IPA 矩阵四象限说明

象限	标签主题	特征	策略建议
I. 优势区 (高声量 + 高态度)	B4. 推荐分享	用户高度参与且评价积极	巩固优势，扩大口碑效应，可作为标杆场景
II. 机会区 (低声量 + 高态度)	B3. 对比决策	讨论不多但体验极佳	加大曝光，引导更多用户进入该阶段，转化潜在需求
III. 低优先级区 (低声量 + 低态度)	B2. 信息搜集	参与少且评价差	暂不重点投入，或需根本性产品/沟通优化
IV. 改进区 (高声量 + 低态度)	B1. 认知了解	讨论热烈但负面情绪多	亟需干预，排查问题（如信息误导、体验落差、舆情风险）

（三）认知了解阶段表现

1、认知了解三级标签情况

（1）认知了解三级标签总体情况

认知了解阶段细分为疾病认知、PCV13 疫苗认知、接种政策认知三个维度。各维度涉及比例和 PCV13 情感如下。

表 30 认知了解三级标签（多选）

三级标签	列百分比	PCV13 情感
PCV13 疫苗认知	72.70%	0.65
接种政策认知	44.60%	0.32
疾病认知	14.10%	0.43

在“认知了解”阶段，用户讨论高度集中于“PCV13 疫苗认知”，情感倾向总体积极；而“接种政策认知”和“疾病认知”声量较低且情感偏中性，反映出公众对疫苗本身的关注远超政策与疾病背景，但对疾病风险的认知仍处于薄弱状态。因此，用户讨论在“认知了解”阶段的信息结构呈现出明显的“重产品、轻疾病”特征，有必要优化。

（2）Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

分析显示，Z 世代妈妈与非 Z 世代妈妈在 PCV13 疫苗相关认知上呈现差异化侧重：非 Z 世代妈妈对疾病本身、PCV13 疫苗的关注度更高，而 Z 世代妈妈对接种政策认知更突出，反映出不同代际妈妈在疫苗信息获取与关注重点上的代际特征。

表 31 Z 世代妈妈“认知了解”三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
疾病认知	14.20%	7.90%
PCV13 疫苗认知	73.30%	47.70%
接种政策认知	44.00%	68.10%

（3）UGC 账号角色

分析显示，宝妈、宝爸、素人类账号更关注疫苗产品认知，表明传播主体以普通用户为主。

表 32 UGC 账号角色下的“认知了解”三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	账号角色				
	KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
疾病认知	20.10%	9.70%	14.40%	8.50%	11.20%
PCV13 疫苗认知	69.90%	67.90%	73.30%	79.40%	73.80%
接种政策认知	46.70%	49.40%	44.00%	44.20%	53.30%

各类 UGC 账号在“认知了解”阶段均高度聚焦 PCV13 疫苗产品本身，其中宝妈账号高达 79.4%，凸显疫苗产品是讨论绝对核心而对疾病认知普遍薄弱；KOL（46.7%）和宝爸（53.3%）对“接种政策认知”关注度显著更高，体现其在传播中承担政策解读与合规性评估功能。

2、认知了解四级标签情况

（1）认知了解四级标签总体情况

PCV13 疫苗相关认知的关注度呈现“重核心、轻细节”的不均衡特征：公众对疾病严重性、疫苗安全性、免疫规划属性等核心认知维度的讨论度极高，但对疾病症状、疫苗认知误区、费用报销等细节类信息的关注度显著偏低，反映出认知体系存在明显的重点聚焦与短板并存的现象。

表 33 认知了解四级标签（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	计数	列百分比
疾病认知	疾病症状认知	320	25.50%
	严重性认知	1022	81.50%
PCV13 疫苗认知	疫苗保护范围认知	3374	52.10%
	疫苗安全性认知	4496	69.40%
	疫苗误区认知	583	9.00%
接种政策认知	免疫规划（免费/自费）认知	3023	76.00%
	费用报销政策认知	543	13.70%
	接种地点政策认知	1133	28.50%

疾病认知：疾病认知的核心高度聚焦于严重性认知，比例远超疾病症状认知，说明公众对儿童肺炎的危害程度有较强的警惕性，但对疾病具体症状的认知较为薄弱，这可能导致对肺炎的早期识别与干预能力不足。

PCV13 疫苗认知：PCV13 疫苗认知的重点集中在疫苗安全性认知（69.40%）和保护范围认知（52.10%），而疫苗误区认知仅为 9.00%，反映出公众最关注疫苗的核心保障属性，但对常见认知误区的了解明显不足，存在认知盲区。

接种政策认知：接种政策认知的核心是免疫规划（免费/自费）认知，而费用报销政策认知和接种地点政策认知的关注度较低，说明公众最关心疫苗的付费属性，但对接种后的报销细节、具体地点等实操性政策信息的关注度不足。

（2）Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

Z 世代妈妈与非 Z 世代妈妈在 PCV13 疫苗相关认知上呈现鲜明的代际分化特征：非 Z 世代妈妈更聚焦于疾病严重性、疫苗基础属性等核心风险类认知，而 Z 世代妈妈则更关注疫苗安全性、费用报销等细节与实操性信息，反映出不同代际妈妈在信息获取偏好与认知重心上的显著差异。

表 34 Z 世代妈妈的“认知了解”四级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	是否 Z 世代妈妈	
		非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
疾病认知	疾病症状认知	25.50%	29.40%
	严重性认知	81.60%	70.60%
PCV13 疫苗认知	疫苗保护范围认知	52.20%	46.60%
	疫苗安全性认知	69.20%	85.40%
	疫苗误区认知	8.90%	14.60%
接种政策认知	免疫规划（免费/自费）认知	76.70%	59.20%
	费用报销政策认知	12.10%	53.70%
	接种地点政策认知	28.40%	31.30%

（3）账号角色

不同账号角色在 PCV13 疫苗认知传播中呈现明确的功能分化。KOL 账号是深度科普与政策细节解读的核心输出者，普通、素人、宝妈、宝爸等大众账号则承担基础认知与生活化信息的传播功能，两者形成互补的传播生态，共同构成疫苗认知的信息传播网络。

表 35 认知了解四级标签：账号角色（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	账号角色				
		KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
疾病认知	疾病症状认知	17.30%	34.50%	25.20%	35.10%	25.00%
	严重性认知	94.20%	70.20%	81.80%	71.90%	83.30%
PCV13 疫苗认知	疫苗保护范围认知	54.10%	46.40%	52.60%	56.20%	53.20%
	疫苗安全性认知	61.90%	70.20%	69.60%	69.20%	64.60%
	疫苗误区认知	9.90%	9.60%	8.90%	7.80%	11.40%
接种政策认知	免疫规划（免费/自费）认知	71.10%	83.70%	75.20%	82.60%	82.50%
	费用报销政策认知	20.70%	9.50%	13.90%	0.80%	1.80%
	接种地点政策认知	25.60%	20.20%	29.60%	27.50%	33.30%

（四）信息搜集阶段表现

1、信息搜集三级标签情况

信息搜集阶段细分为线上渠道和线下渠道两个维度。各维度涉及比例如下。

表 36 信息搜集三级标签（多选，列百分比）

三级标签	计数	比例
线上渠道	3008	71.80%
线下渠道	2678	64.00%

71.8%的信息提及量来自线上渠道，且样本量（3008）显著高于线下，说明线上平台（社交媒体、医疗科普号、电商平台等）是品牌声量的主要来源，也是用户主动了解疫苗的核心场景。

线下是信任转化的关键场，64%的比例说明线下渠道（社区医院、儿科门诊、疾控中心等）依然是重要的信息触点。对于疫苗这类高决策成本的医疗产品，线下专业医护人员的讲解和推荐，能极大提升用户的信任度，是线上信息的重要验证环节。

另外，两个渠道比例相加大于 100%，表面有大量用户同时通过线上、线下获取信息。这说明目标人群对疫苗信息的准确性、可信度有较高要求，会主动交叉验证，也意味着单一渠道很难完全触达和说服用户。

2、Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

分析显示，Z 世代妈妈在 PCV13 疫苗的信息搜集上呈现“线上线下双渠道高同步依赖”的鲜明特征，其线上、线下渠道的信息获取比例不仅显著高于非 Z 世代妈妈，且两类渠道的依赖度持平，反映出她们更倾向于通过“线上广泛触达+线下专业验证”的组合方式，来获取更全面、可信的疫苗信息。

表 37 信息搜集三级标签：Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
线上渠道	71.70%	74.80%
线下渠道	63.50%	74.80%

3、账号角色

分析显示，线上疫苗信息更多来自普通用户的自发分享，宝爸群体在线上信息传播中的活跃度甚至超过宝妈，反映出育儿场景中父母双方共同参与信息搜集的趋势。而线下场景中，KOL 的专业推荐（如儿科医生、育儿博主的线下讲座/门诊推荐）是用户获取疫苗信息的核心来源，同时宝爸宝妈在线下场景的信息传播中也扮演着重要的口碑传递角色。

表 38 信息搜集三级标签：账号角色（多选，列百分比）

三级标签	账号角色				
	KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
线上渠道	66.00%	77.40%	71.60%	68.00%	74.40%
线下渠道	76.00%	54.70%	64.30%	66.90%	66.70%

（五）对比决策阶段表现

1、对比决策三级标签情况

（1）对比决策三级标签总体情况

对比决策阶段细分为疫苗属性因素、接种经济成本因素、接种便利性因素、风险收益因素、孩子自身因素等五个维度。各维度涉及比例如下。

表 39 对比决策三级标签（多选，列百分比）

三级标签	计数	比例
疫苗属性因素	6427	86.70%
接种经济成本因素	3763	50.80%
接种便利性因素	936	12.60%
风险收益因素	4920	66.40%
孩子自身因素	4111	55.40%

用户在 PCV13 疫苗对比决策话题讨论中呈现“重产品、重安全、轻便利”的声量结构：疫苗属性与风险收益是核心考量，经济成本构成重要门槛，孩子个体适配性日益受关注，而接种便利性讨论相对较少。

（2）Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

分析显示，Z 世代妈妈与非 Z 世代妈妈在对比决策维度上呈现显著的“精细化决策”差异。

表 40 Z 世代妈妈在“对比决策”三级标签表现（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
疫苗属性因素	86.50%	95.10%
接种经济成本因素	50.40%	62.70%
接种便利性因素	12.30%	23.80%
风险收益因素	65.80%	87.60%
孩子自身因素	55.00%	71.40%

Z 世代妈妈在所有三级标签上的关注比例均高于非 Z 世代妈妈，其中风险收益因素（87.60%vs65.80%）、孩子自身因素（71.40%vs55.00%）、疫苗属性因素（95.10%vs86.50%）的差距尤为明显，且接种便利性因素（23.80%vs12.30%）的关注度近乎翻倍。这一特征表明 Z 世代妈妈的决策更趋全面、严谨，既极致关注疫苗核心价值与风险平衡，也重视孩子个体适配性，同时对就医体验的便捷性要求更高，体现出“精细化、个性化、体验化”的决策趋势。

（3）账号角色

不同 UGC 角色在对比决策阶段关注焦点显著分化。素人账号聚焦疫苗本身属

性与风险收益，是深度对比的核心信源；宝妈强调孩子个体适配与安全性；宝爸则最关注经济成本，凸显性别角色在决策中的差异化权重。

表 41 账号角色在“对比决策”三级标签的表现（多选，列百分比）

三级标签	账号角色				
	KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
疫苗属性因素	77.20%	77.80%	87.50%	85.90%	81.30%
接种经济成本因素	44.10%	52.10%	50.80%	58.30%	65.60%
接种便利性因素	12.60%	6.90%	13.00%	12.20%	6.30%
风险收益因素	60.60%	58.80%	67.00%	71.30%	56.30%
孩子自身因素	47.20%	53.10%	55.80%	62.90%	56.30%

2、对比决策四级标签情况

（1）对比决策四级标签总体情况

四级标签的分布进一步揭示了用户对比决策的核心细节，呈现“安全优先、年龄适配、风险敏感”的特征。

表 42 对比决策四级标签（多选）

三级标签	四级标签	计数	列百分比
疫苗属性因素	安全性因素	4058	72.60%
	有效性因素	2594	46.40%
	技术工艺因素	1939	34.70%
	品牌信任因素	2993	53.50%
风险收益因素	接种收益因素	2417	61.30%
	不良反应风险因素	3153	79.90%
孩子自身因素	年龄阶段因素	3036	88.10%
	健康状况因素	1342	38.90%

疫苗属性因素中，安全性因素（72.60%）比例遥遥领先，其次是品牌信任因素（53.50%）、有效性因素（46.40%），技术工艺因素（34.70%）比例最低，表明用户最关注疫苗安全保障与品牌可信度，对技术细节的关注度较低；

风险收益因素中，不良反应风险因素（79.90%）显著高于接种收益因素（61.30%），反映家长决策时“避害优先于趋利”的谨慎心态，对疫苗潜在风险的敏感度远超收益预期；

孩子自身因素中，年龄阶段因素（88.10%）比例极高，健康状况因素（38.90%）比例不足四成，说明孩子年龄是判断接种适配性的核心标准，健康状况仅为辅助考量。

（2）Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

Z世代与非Z世代妈妈在疫苗决策中呈现鲜明代际差异，非Z世代以“风险规避+经验规则”为主导，Z世代则体现“安全底线+收益导向+个体化评估”的主动、精细化决策模式。

表 43 Z世代妈妈在“对比决策”四级标签的表现（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	是否 Z 世代妈妈	
		非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
疫苗属性因素	安全性因素	72.50%	76.90%
	有效性因素	46.00%	59.90%
	技术工艺因素	34.60%	38.80%
	品牌信任因素	53.50%	53.70%
风险收益因素	接种收益因素	60.80%	76.00%
	不良反应风险因素	80.10%	75.20%
孩子自身因素	年龄阶段因素	88.00%	90.80%
	健康状况因素	38.40%	54.20%

疫苗属性：两类妈妈均将安全性置于首位（Z世代76.90% > 非Z世代72.50%），但Z世代对有效性（59.90% vs 46.00%）和技术工艺（38.80% vs 34.60%）关注度显著更高，显示其不盲信品牌，更倾向通过专业信息验证价值。

风险收益：非Z世代高度聚焦不良反应风险（80.10%），远超过收益的关注（60.80%），体现“避害优先”；而Z世代收益认知（76.00%）略超风险担忧（75.20%），转向“获益驱动”。

孩子自身因素：非Z世代主要依赖年龄规则（88.00%），忽视个体健康状况（仅38.40%）；Z世代在同样重视年龄（90.80%）基础上，显著提升对健康状况（54.20%）的考量，决策更具个性化与医学意识。

整体表明，Z世代妈妈正从被动遵从转向主动研究，其决策融合科学素养、个体适配与价值权衡，对传播内容的专业性、透明度与个性化提出更高要求。

（3）账号角色

不同UGC角色在疫苗决策关注点上高度分化，宝爸最重技术与效果，宝妈聚焦孩子健康与风险，素人以安全体验为核心参考，KOL侧重传递接种收益，普通账号则承担基础信息扩散功能。该分布表明，**精准沟通需“因角施策”**：向宝爸强调技术数据，向宝妈强化安全适配，借素人夯实信任基础，由KOL塑造价值认知。

表 44 账号角色在“对比决策”四级标签的表现（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	账号角色				
		KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
疫苗属性因素	安全性因素	69.90%	66.60%	73.00%	68.70%	52.20%
	有效性因素	43.00%	40.40%	46.80%	43.90%	63.00%
	技术工艺因素	30.10%	21.80%	35.60%	25.00%	41.30%
	品牌信任因素	54.80%	40.40%	54.30%	50.20%	56.50%
风险收益因素	接种收益因素	63.90%	54.50%	61.60%	62.20%	51.90%
	不良反应风险因素	80.30%	78.20%	80.00%	81.50%	77.80%
孩子自身因素	年龄阶段因素	83.00%	89.90%	88.00%	90.60%	87.50%
	健康状况因素	43.40%	42.00%	38.60%	47.60%	43.80%

（六）推荐分享阶段表现

1、推荐分享三级标签情况

推荐分享阶段的内容分布呈现“实用建议主导、体验反馈为辅”的特征，疫苗选择建议（49.00%）、疫苗接种后反应（48.10%）、疫苗接种体验（47.60%）三者比例接近且均居高位，成为用户分享的核心内容，反映出“决策参考-效果反馈-体验传递”的分享逻辑；疫苗接种注意事项（36.70%）比例次之，为后续接种用户提供实操指导；疫苗接种攻略（22.30%）比例最低，说明用户更倾向于分享具体体验与建议，而非系统性攻略内容。

表 45 推荐分享三级标签（多选，列百分比）

三级标签	计数	比例
疫苗接种攻略	2751	22.30%
疫苗接种体验	5875	47.60%
疫苗接种后反应	5943	48.10%
疫苗选择建议	6056	49.00%
疫苗接种注意事项	4533	36.70%

2、Z 世代妈妈/非 Z 世代妈妈

Z 世代妈妈与非 Z 世代妈妈在推荐分享行为上呈现显著的“代际差异”，Z 世代妈妈在所有三级标签上的分享比例均远超非 Z 世代妈妈，其中疫苗接种注意事项（66.80%vs35.90%）、疫苗选择建议（65.50%vs48.60%）、疫苗接种体验（61.80%vs47.20%）的差距最为明显，且各维度比例均超过 60%。这一特征印证了 Z 世代妈妈“社交化参与决策”的趋势，她们更乐于通过分享接种细节、选择建议等内容，参与育儿圈层的交流与价值传递，成为口碑传播的核心力量。

表 46 Z 世代妈妈在“推荐分享”三级标签的表现（多选，列百分比）

三级标签	是否 Z 世代妈妈	
	非 Z 世代妈妈	Z 世代妈妈
疫苗接种攻略	22.00%	33.90%
疫苗接种体验	47.20%	61.80%
疫苗接种后反应	47.80%	61.50%
疫苗选择建议	48.60%	65.50%
疫苗接种注意事项	35.90%	66.80%

3、账号角色

在推荐分享阶段，不同 UGC 角色形成互补型内容生态：宝妈主导实操经验传递，素人提供真实体验佐证，KOL 引领专业选择建议，普通账号与宝爸则补充基础攻略与理性视角。

表 47 账号角色在“推荐分享”三级标签的表现（多选，列百分比）

三级标签	账号角色				
	KOL 账号	普通账号	素人账号	宝妈账号	宝爸账号
疫苗接种攻略	25.20%	32.80%	21.30%	33.40%	26.60%
疫苗接种体验	33.80%	32.80%	49.10%	38.60%	43.00%
疫苗接种后反应	28.40%	38.10%	49.40%	50.60%	39.10%
疫苗选择建议	62.60%	46.30%	49.00%	52.10%	56.30%
疫苗接种注意事项	26.10%	36.70%	36.90%	53.20%	42.20%

（七）小结

基于对 65,182 条儿童家长 UGC 数据的系统分析，本章围绕用户在 PCV13 疫苗决策过程中的行为路径、态度倾向展开研究，主要有以下发现。

1、用户决策旅程呈现社交媒体传播的“沙漏模型”特征，两端高、中间低。社媒讨论在用户决策旅程中分布不均，正由传统“漏斗模型”转向“沙漏模型”，即“认知了解”（50.60%）与“推荐分享”（51.20%）阶段参与度超半数，而“信息搜集”阶段比例偏低（15.80%），“对比决策”处于中间水平（27.20%）。

上述结果表明用户高度关注“知识获取”与“经验分享”，但在主动深度搜寻信息环节参与不足，反映出社媒环境下信息被动触达强、主动验证弱的特点，从侧面表明品牌需在信息可信度与可及性上加强建设。

2、“声量-态度”IPA 矩阵揭示内容生成方向，有必要提升认知了解和对比决策内容主题

通过“声量-态度”IPA 矩阵分析表明，将用户决策旅程各级标签作为内容主题开展品牌沟通过程中，“对比决策”内容主题为潜在机会区，虽讨论较少但体

验极佳，具备转化潜力；而“认知了解”内容主题位于改进区，需针对性优化以提升整体传播效能。当前传播在用户决策旅程前端引发大量讨论但情感偏负面（如信息混乱、疑虑多），用户决策旅程后端口碑良好但中间决策环节未充分激活。因此有必要重点干预认知内容主题，并引导更多用户进入高满意度的对比决策环节以释放转化潜力。

3、用户决策旅程匹配四大内容营销主题场景，通过差异化沟通重点，企业实现精准内容供给

认知了解阶段：72.7%集中于“PCV13 疫苗认知”（如是什么、防什么、是否安全），仅 14.1%涉及疾病本身。用户讨论兴趣点在疫苗而非疾病。因此，内容策略应以疫苗为核心载体，通过通俗化语言解释其保护范围、免疫机制、适用年龄等，避免过度前置医学化疾病描述；可将疾病危害作为佐证信息嵌入产品介绍中，提升必要性感知。

信息搜集阶段：71.8%通过线上渠道获取信息，64.0%同步线下验证，体现“线上广触达+线下强信任”的交叉验证模式。因此，需构建线上线下协同的信息生态，线上强化医生/KOL 科普、真实接种问答；线下推动社区医院、儿科门诊提供标准化咨询物料，确保信息一致性，降低用户验证成本。

对比决策阶段：86.7%聚焦“疫苗属性因素”（安全性、有效性、品牌信任），仅 12.6%关注“接种便利性”。此阶段是技术沟通黄金窗口，内容应突出临床数据、血清型覆盖、不良反应率等硬核指标，提供结构化对比工具（如品牌对比表、适配自测问卷），帮助用户理性锚定选择。

推荐分享阶段：近 50%围绕“疫苗选择建议”“接种后反应”“个人体验”展开，强调实用性与结果导向。因此，应系统化激发用户生成内容（UGC）。鼓励宝妈、素人发布结构化接种日记（如“第 X 天反应记录”、“选择理由清单”），并通过话题运营放大真实口碑，形成可复制、可参考的社交证据链。

4、Z 世代妈妈驱动“社交化参与决策”新范式

Z 世代妈妈在信息搜集（32.10% vs 15.50%）、对比决策（47.10% vs 26.90%）及推荐分享（80.10% vs 50.70%）阶段参与度显著高于非 Z 世代，且更关注安全性、有效性、费用报销等细节。因此，Z 世代妈妈从“被动接受信息”转向“主动研究+社交分享”，其决策更精细化、理性化、体验化，对内容专业性与透明

度提出更高要求，是未来口碑传播的核心驱动力。

5、账号角色功能分化明确，形成互补传播生态

不同 UGC 角色在用户决策旅程中承担差异化职能，普通用户贯穿全程，KOL 强化信息搜集，素人支撑对比决策，宝妈主导推荐分享。

其中，普通账号在“认知了解”（62.30%）和“推荐分享”（57.00%）占主导，是声量基本盘；KOL 账号在“信息搜集”阶段作用突出（56.20%），提供权威解读；素人账号在“对比决策”（28.30%）与“推荐分享”（52.10%）具真实参考价值；宝妈账号高度聚焦疫苗认知（79.40%）与实操分享（注意事项 53.20%），是母婴圈层意见核心。

6、产品声量随用户决策旅程分化，反映产品生命周期与用户信任差异

各品牌产品在用户旅程中呈现差异化声量轨迹，体现其市场定位与用户关系成熟度。其中，**优佩欣（新上市）**表现为“**认知强（60.00%）、后续弱（推荐 35.00%）**”，**尚未建立体验闭环**；**沃安欣**表现为推荐分享声量高达 67.70%，用户满意度与传播意愿相对突出；**沛儿 13** 在信息搜集（27.80%）、对比决策（70.60%）与推荐分享（60.10%）阶段均保持高位，成功构建“主动搜寻—高决策意愿—积极分享”的成熟正向循环，自传播效应显著；**维民菲宝**初始认知声量相对平稳，但在对比决策（68.40%）与推荐分享（62.10%）阶段声量持续攀升，体现出用户信任度随决策推进稳步增强。

四、社媒分布分析

（一）社媒平台分布情况

1、社媒平台总体情况

（1）各社媒平台声量及 PCV13 情感表现

根据近一年的 PCV13 疫苗在六个社媒平台的声量及情感分析，小红书和抖音是 PCV13 疫苗话题的主阵地，但情感倾向整体偏中性；其中小红书声量占比最高且情感相对积极，抖音虽为第二高声量平台但情感得分最低，反映出两大平台在讨论热度与情绪基调上的显著差异。

表 48 PCV13 疫苗社媒平台分布及情感

社媒平台	列百分比	PCV13 情感
小红书	46.71%	0.17
抖音	34.34%	0.09
微博	14.70%	0.10
快手	3.60%	0.13
知乎	0.45%	0.08
哔哩哔哩	0.20%	0.04

小红书：声量占比达 46.71%，为绝对主导平台，情感得分为 0.17，是所有平台中唯一高于 0.10 的正向值，表明用户在此平台对 PCV13 疫苗的讨论不仅活跃，且整体态度趋于正面。

抖音：声量占比 34.34%，位居第二，但情感得分为 0.09，为所有平台中最低之一，显示其传播以信息触达为主，用户情绪偏向中性甚至略负，可能受短视频碎片化、广告泛滥或争议性内容影响。

微博：声量占比 14.70%，情感得分为 0.10，处于中等水平，体现其作为公共舆论场的属性，讨论多由热点事件驱动，情绪波动较小，稳定性较强。

快手：声量占比 3.60%，情感得分为 0.13，虽声量较低但情感略高于抖音，反映下沉市场用户在有限发声中仍保持一定认可度。

知乎：声量占比 0.45%，情感得分为 0.08，声量极低且情绪中性偏弱，符合其知识问答社区的理性调性，讨论较少且缺乏情感共鸣。

哔哩哔哩：声量占比仅 0.20%，情感得分为 0.04，几乎无相关讨论，说明该平台用户对 PCV13 疫苗话题兴趣极低，内容生态不匹配。

PCV13 疫苗相关声量高度集中于小红书与抖音，形成“双核驱动”格局；但

两者在情绪表达上存在明显分化，小红书以高声量+微正向情感成为口碑建设主战场，抖音则以高曝光+中性情绪承担广域触达功能。品牌应根据不同平台的情感特征，制定差异化沟通策略，在小红书强化真实体验与信任构建，在抖音注重科普准确性与风险规避。

(2) 各平台传播趋势

PCV13 疫苗社媒传播呈现“小红书高波动引领、抖音中位声量稳定、其余平台声量较弱”的分化格局。小红书平台传播声量出现超 4000 的强峰值且波动显著，抖音维持 1500-2500 区间稳定输出，而微博、快手、知乎、哔哩哔哩等平台传播声量偏低，整体传播结构呈现“头部平台主导、长尾平台跟进”的特征。

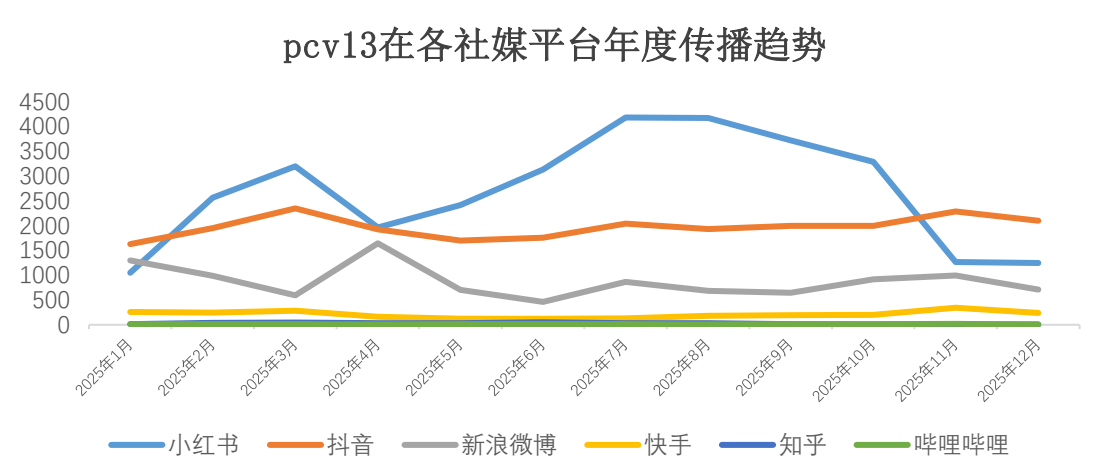


图 4 PCV13 在各社媒平台年度传播趋势

2、账号类型

(1) 总体表现

关于 PCV13 的社媒讨论生态呈“金字塔”分布，“大众基底（素人/普通用户）+ 中层扩散（宝妈/KOL）+ 顶层稀缺（官方/医生/媒体）”结构。真实用户体验分享是基本盘，但缺乏顶层权威声音的深度参与和引导。从对 PCV13 情感来看，宝妈账号态度相对最积极正面。

表 49 账号类型分布及 PCV13 情感得分

账号类别	列百分比	PCV13 情感
官方政务账号	0.54%	0.07
机构/企业账号	2.16%	0.13
医生账号	0.88%	0.07
媒体账号	0.42%	0.09

专业人士账号	0.57%	0.10
KOL 账号	4.44%	0.12
普通账号	8.71%	0.10
素人账号	86.19%	0.09
宝妈账号	9.68%	0.14
宝爸账号	0.87%	0.08

素人与普通用户是社媒讨论的绝对主力，“素人账号”（86.19%）和“普通账号”（8.71%）两者合计超过 94%，其讨论内容多源于真实的接种经历、信息求证和育儿交流，构成了 PCV13 疫苗话题的基层舆论场。

宝妈与商业机构是情感倾向的积极高地，从情感得分看，“宝妈账号”（0.14）和“机构/企业账号”（0.13）得分较高，其次为“KOL 账号”（0.12）。宝妈群体作为核心决策者，她们在分享中流露出最高的积极情绪，是正面口碑的主要来源，表明这个群体对 PCV13 疫苗的认可度。

（2）社媒平台维度

从声量看，高声量平台（小红书、抖音、微博）的账号分布，决定了市场舆论的主要面貌和用户决策的关键触点；而低声量平台（快手、知乎、B 站）的分布特征，则反映了特定圈层的边缘化生态。

表 50 不同账号类型在各平台分布（多选，列百分比）

账号类别	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
官方政务账号	0.05%	4.09%	0.24%	1.17%	1.46%	1.62%
机构/企业账号	1.48%	1.66%	2.54%	9.31%	3.65%	13.64%
医生账号	0.75%	1.64%	1.71%	1.13%	3.65%	3.25%
媒体账号	0.02%	3.38%	0.09%	0.12%	0.00%	3.90%
专业人士账号	0.53%	0.30%	1.00%	1.61%	0.00%	0.00%
KOL 账号	0.86%	25.85%	4.41%	5.88%	5.11%	2.92%
普通账号	2.19%	11.32%	22.32%	20.56%	15.33%	6.49%
素人账号	96.95%	62.83%	73.27%	73.56%	79.56%	90.58%
宝妈账号	10.82%	0.60%	12.26%	8.87%	3.65%	2.60%
宝爸账号	1.16%	0.24%	0.79%	0.36%	2.92%	0.00%

高声量平台中，小红书与抖音两者素人账号占比均极高（小红书 96.95%，抖音 73.27%），且宝妈账号占比突出（小红书 10.82%，抖音 12.26%），直观反映出两大平台在母婴领域的内容活跃度。微博成为 KOL 与机构主导的公共舆论场，其中 KOL 账号占比高达 25.85%，媒体账号（3.38%）和官方政务账号（4.09%）占

比也显著高于其他平台。素人账号占比（62.83%）为全平台最低。这呈现出典型的“中心化”传播结构。

因此，PCV13 疫苗的社媒舆论主战场（小红书、抖音、微博）已形成稳固的“生态分工”，小红书和抖音是口碑信任的基石，微博是舆论声量的策源地。品牌的全域策略要针对这三者采取差异化运营。其中，小红书和抖音这两个平台沉淀了规模相对庞大的母亲用户群体，她们的内容因其身份的真实感和代入感，对其他家长的决策具有极强的参考价值和说服力，是口碑传播链条中的关键枢纽。

3、主贴类型

（1）总体情况

PCV13 疫苗社媒讨论并非由品牌或官方宣传主导，而是由海量用户真实的信息需求（科普、咨询）与决策需求（产品推荐、比较、体验分享）所塑造。

表 51 主贴类型分布及 PCV13 情感得分

主贴类型	列百分比	PCV13 情感
科普知识类	46.05%	0.15
个人体验分享	30.06%	0.12
咨询讨论类	32.71%	0.13
产品推荐类	34.76%	0.18
产品比较类	18.85%	0.17
政策宣传类	6.18%	0.13
广告宣传类	8.48%	0.14

科普需求是基本盘，奠定理性认知基础。科普知识类主贴以 46.05%的占比遥遥领先，其 PCV13 情感值（0.15）也处于积极区间。这表明在用户决策旅程的起点，获取权威、科学的疫苗知识是最大规模、最普遍的需求。海量的科普内容构成了社媒讨论的“压舱石”，为整个话题奠定了偏理性的基调。

产品信息驱动深度决策，用户主动比较与关注。产品推荐类（34.76%）与产品比较类（18.85%）合计占比超过 53%，且情感值（0.18, 0.17）在所有类型中最高。当用户从基础认知进入决策阶段，对具体产品的作用、差异等的关注度上升。极高的积极情感表明，用户主动搜索、讨论和推荐产品时，普遍带有明确的选择倾向和较高的满意度预期。

体验分享与咨询是信任枢纽，反映真实决策动态。个人体验分享（30.06%）与咨询讨论类（32.71%）均占据约三分之一的重要份额，情感值中性偏积极（0.12,

0.13)。这两类内容是用户决策心理的“实时映射”，共同构成了口碑传播和用户互助的核心地带，是观察市场真实反馈、发现用户痛点的最佳窗口。

从对品牌的策略上来看，巩固在科普知识领域的权威地位，将其作为防御性策略，另外可重点聚焦产品比较和咨询讨论场景，通过清晰传达差异化优势，并积极解答用户疑问来切入市场。鼓励真实的个人体验分享是快速建立口碑的有效途径。

(2) 社媒平台维度

平台生态决定内容心智，用户在不同平台主动消费的内容类型，由该平台的底层属性决定。小红书/抖音是大众消费决策与生活分享社区，微博是公共信息广场，知乎是深度研究场，B站是小众共鸣圈。

表 52 不同主贴类型在各平台分布（多选，列百分比）

主贴类型	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
科普知识类	44.90%	53.60%	44.50%	47.10%	40.70%	54.70%
个人体验分享	31.40%	25.50%	30.10%	30.00%	33.90%	24.30%
咨询讨论类	33.90%	26.40%	33.70%	32.00%	34.70%	26.70%
产品推荐类	35.50%	31.60%	35.00%	34.60%	34.70%	32.40%
产品比较类	19.00%	19.80%	18.20%	18.80%	20.30%	23.50%
政策宣传类	5.50%	11.00%	5.30%	6.00%	7.60%	13.00%
广告宣传类	8.40%	8.50%	8.60%	8.70%	8.50%	6.90%

小红书与抖音：需求高度一致的“大众决策双引擎”。两者结构高度相似，均以“科普知识类”（约 44%）、“产品推荐类”（约 35%）、“咨询讨论类”（约 34%）和“个人体验分享”（约 31%）为四大支柱。这两个平台是大众消费者进行信息获取、产品评估、做出购买决定并分享口碑的核心生活场域。

微博：独特的“公共信息广场”，兼具宣导与大众咨询。科普知识类（53.60%）和政策宣传类（11.00%）占比较高，同时咨询讨论类（26.40%）也有相当比例。在高声量加持下，微博呈现“混合器”特点。它既是媒体、政务账号发布权威科普与政策的核心渠道，也是大众用户提出普遍性质疑、参与公共讨论的空间。这使其公共信息广场特性得以凸显。

知乎：专业理性的“决策智库”，但受众圈层有限。科普知识类（54.70%）和产品比较类（23.50%）占比均为全平台最高，政策宣传类（13.00%）占比也显著偏高。用户来此的核心目的是获取深度、系统的科普和进行严肃的产品横向对比，以为决策提供依据。然而，鉴于其整体声量有限，知乎是一个影响高知、深度研究型用户的精准高地，而非大众舆论场。

（二）内容主题

1、总体表现

分析显示，不同社媒平台在用户决策旅程中呈现显著的“阶段聚焦”差异，平台的内容形态与用户属性影响决策环节分布。

表 53 不同社媒平台下用户决策旅程比例（多选，列百分比）

二级标签	社媒平台					
	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
认知了解	44.80%	46.00%	59.00%	76.90%	71.10%	71.70%
信息搜集	22.30%	8.80%	7.20%	3.90%	2.20%	15.20%
对比决策	32.40%	37.30%	17.80%	10.20%	4.40%	41.30%
推荐分享	57.00%	64.00%	40.70%	27.80%	33.30%	32.60%

具体看，小红书和微博以“推荐分享”为主导，抖音与快手侧重“认知了解”，知乎则在“对比决策”环节表现突出。因此，企业在推广 PCV13 疫苗时，应分阶段布局平台策略，例如前期依托短视频平台触达广泛人群，中期引导至知乎等平台进行科学说服，后期通过小红书和微博实现用户自发传播。

2、“认知了解”标签的社媒分布

（1）三级标签的社媒分布

分析显示，各平台在疾病认知、PCV13 疫苗认知、接种政策认知这三类内容上的讨论有所差异。

表 54 认知了解三级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级标签	社媒平台					
	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
疾病认知	17.30%	11.90%	7.90%	13.90%	25.00%	42.90%
PCV13 疫苗认知	80.00%	33.30%	71.00%	68.00%	68.80%	42.90%
接种政策认知	40.80%	69.50%	43.90%	50.20%	31.30%	61.90%

小红书声量规模远超其他平台，同时 PCV13 疫苗认知比例高达 80.00%，这意味着小红书是疫苗产品口碑发酵的核心场域，疾病和政策认知仅作为辅助决策的背景。

抖音声量绝对值位居第二，PCV13 疫苗认知比例（71.00%）同样处于高位，这体现出平台内容以产品展示和场景化推荐为主导，短视频形式擅长通过直观体验驱动感知与传播。

微博声量绝对值位居第三，接种政策认知比例（69.50%）最高。这明确了其作为政策发布、公共议题讨论和舆情发酵核心平台的角色，用户更关注宏观动向与官方信息。

快手声量绝对值较少，PCV13 疫苗认知（68.00%）和接种政策认知（50.20%）的声量比例均处于较高水平，疾病认知（13.90%）较低。这反映了下沉市场用户对产品本身和接种便利性、合规性等实用信息的双重关注。

知乎声量绝对值最少，三项认知比例呈现独特均衡性：接种政策认知（61.90%）、PCV13 疫苗认知（42.90%）、疾病认知（42.90%）均处于高位。这标志着其用户倾向于进行从疾病危害、产品技术到政策依据的全链条深度调研，决策路径最为系统和理性。

（2）四级标签的社媒分布

分析显示，知识型平台（知乎、哔哩哔哩）聚焦深度疾病认知与政策细节解读，生活分享类平台（小红书、抖音、快手）侧重疫苗实用信息与基础政策认知，资讯类平台（微博）则成为政策细节扩散的核心阵地，各平台在认知传播中形成了差异化的功能定位。

表 55 认知了解四级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级 标签	四级标签	社媒平台					
		小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
疾病认 知	疾病症状认知	24.10%	25.50%	32.80%	30.60%	0.00%	0.00%
	严重性认知	83.10%	81.60%	73.60%	77.80%	100.00%	100.00%
PCV13 疫苗认 知	疫苗保护范围认知	55.40%	28.40%	47.40%	61.40%	9.10%	55.60%
	疫苗安全性认知	70.70%	77.10%	66.40%	59.70%	54.50%	55.60%
	疫苗误区认知	9.10%	8.40%	9.30%	3.40%	36.40%	11.10%
接种政 策认知	免疫规划 （免费/自费）认知	80.40%	42.90%	83.80%	88.50%	60.00%	23.10%
	费用报销政策认知	0.00%	92.70%	0.00%	0.00%	0.00%	84.60%
	接种地点政策认知	31.50%	30.80%	23.10%	15.40%	40.00%	15.40%

疾病认知：疾病认知呈现平台分层。知乎、哔哩哔哩对“疾病严重性认知”的讨论比例达 100%，是深度科普疾病危害的核心平台。而“疾病症状认知”主要集中在小红书、微博、抖音、快手等生活与资讯平台，知识型平台未见覆盖，表

明症状认知更依赖生活化分享场景。

PCV13 疫苗认知：不同平台在疫苗认知传播中功能分化明显。微博、小红书是“疫苗安全性认知”的主要渠道（微博 77.1%，小红书 70.7%），呼应大众核心关切。哔哩哔哩在“疫苗误区认知”上比例突出（36.4%），适合进行深度辟谣。“疫苗保护范围认知”在快手（61.4%）、小红书（55.4%）与知乎（55.6%）均有较高渗透，属于多平台传播的实用信息。

接种政策认知：政策认知的传播高度聚焦且场景化。“费用报销政策认知”几乎仅存在于微博（92.7%）与知乎（84.6%），是资讯与知识型平台的专属议题。“免疫规划（免费/自费）认知”则在快手（88.5%）、抖音（83.8%）和小红书（80.4%）等生活分享平台更普及，构成基础政策认知的主渠道。相比之下，“接种地点政策认知”在各平台占比均未超过 40%，是当前传播中的薄弱环节。

3、“信息搜集”标签的社媒分布

分析显示，线上渠道高度集中在内容聚合型平台，而线下渠道仅在生活分享/下沉市场平台零散渗透，不同平台对两类信息的承载能力差异极大。表明线下疫苗信息的线上传播场景非常有限，仅在贴近日常育儿分享的平台有零散曝光，传播范围和声量远不及线上渠道。

表 56 信息搜集三级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级标签	社媒平台					
	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
线上渠道	71.10%	100.00%	76.20%	52.20%	100.00%	0.00%
线下渠道	66.10%	0.00%	52.50%	65.20%	0.00%	0.00%

4、“对比决策”标签的社媒分布

（1）三级标签的社媒分布

不同社媒平台在对比决策环节的功能分化极为显著，呈现“垂直平台聚焦核心、综合平台侧重单一”的格局。

表 57 对比决策三级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级标签	社媒平台					
	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
疫苗属性因素	90.70%	2.50%	76.50%	74.30%	100.00%	0.00%
接种经济成本因素	51.40%	0.00%	49.50%	59.50%	50.00%	0.00%
接种便利性因素	15.10%	0.00%	5.30%	5.40%	50.00%	0.00%
风险收益因素	71.20%	0.00%	52.90%	54.10%	50.00%	0.00%
孩子自身因素	58.30%	97.50%	45.80%	48.60%	0.00%	0.00%

小红书声量规模居各平台首位，疫苗属性因素比例高达 90.70%，远高于其他因素，风险收益（71.20%）、经济成本（51.4%）与孩子自身因素（58.30%）也有相当比例。这印证了小红书是产品口碑与综合决策的核心平台，用户高度关注疫苗本身，并会结合成本、孩子情况等多维度进行考量。

抖音声量规模仅次于小红书，疫苗属性因素（76.50%）同样占据绝对核心，其他因素比例均未超过 53%。作为短视频平台，其海量声量有助于疫苗核心信息快速、直观触达用户，推动形成初步认知，决策考量相对简化。

微博声量规模位居第三，孩子自身因素比例高达 97.50%，疫苗属性因素仅 2.50%，其余因素均为 0%。表明微博上相关讨论几乎完全围绕儿童个体状况展开，与政策、新闻等公共话题中涉及具体儿童的案例高度相关，决策因素高度集中。

快手声量规模较小，聚焦下沉市场用户，疫苗属性因素（74.30%）是首要考量，同时接种经济成本因素（59.50%）显著高于其他平台。这反映出下沉市场用户在决策时，在关注疫苗品质的同时，对价格极为敏感，凸显其务实特性。

B 站声量规模同样较小，疫苗属性因素比例为 100%，同时接种经济成本、便利性及风险收益因素均占 50%，孩子自身因素为 0%。这体现了其用户群体倾向于进行理性、宏观的多维度成本收益分析，决策逻辑偏重科学评估，是进行深度科普与专业形象建设的精准场景。

（2）四级标签的社媒分布

四级标签的平台分布延续了“功能分化、场景适配”的特征。

表 58 对比决策四级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级标签	四级标签	社媒平台					
		小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
疫苗属性因素	安全性因素	74.80%	0.00%	65.00%	52.30%	50.00%	0.00%
	有效性因素	49.90%	100.00%	33.50%	45.50%	50.00%	0.00%
	技术工艺因素	38.60%	100.00%	20.80%	13.60%	100.00%	0.00%
	品牌信任因素	54.80%	0.00%	49.10%	43.20%	100.00%	0.00%
风险收益因素	接种收益因素	64.00%	0.00%	49.80%	60.00%	100.00%	0.00%
	不良反应风险因素	80.10%	0.00%	79.60%	73.30%	100.00%	0.00%
孩子自身因素	年龄阶段因素	87.20%	84.40%	91.60%	96.90%	0.00%	0.00%
	健康状况因素	40.20%	21.90%	33.10%	59.40%	0.00%	0.00%

小红书作为母婴群体多维度综合决策的核心种草阵地，用户以疫苗安全性（74.80%）、孩子年龄适配性（87.20%）和不良反应风险（80.10%）为核心决策锚点，同时关注品牌信任（54.80%）与接种收益（64.00%），体现了母婴群体谨慎验证、依赖多维度信息交叉判断的决策心理，是品牌传递产品核心价值的关键场域。

微博作为公共舆论场，用户主要聚焦疫苗属性维度的有效性（100%）与工艺技术（100%）。这反映出微博用户在该阶段的讨论由公共热点或专业议题驱动，更关注疫苗技术层面的公共话题，而非个人接种的全维度决策，心理上偏向参与公共议题而非个人决策。

抖音作为短视频场景下的快速决策阵地，用户核心关注疫苗不良反应风险（79.60%）与孩子年龄适配性（91.60%），同时重视疫苗安全性（65.00%）与品牌信任（49.10%）。这贴合短视频“短平快”的传播节奏，呈现出用户优先评估核心风险与适配条件，以快速形成决策的心理特点。

快手作为下沉市场务实决策的核心阵地，用户高度关注孩子年龄（96.90%）与健康状况（59.40%）的适配性，同时权衡疫苗不良反应风险（73.30%）与接种收益（60.00%），并关注疫苗安全（52.30%）与效果（45.50%）。体现了下沉市场用户在遵循普遍规则的基础上，尤为重视孩子个体情况的精细化、务实性决策逻辑。

5、“推荐分享”标签的社媒分布

不同社媒平台的推荐分享内容呈现“平台属性决定分享侧重”的鲜明特征。

表 59 推荐分享三级标签：社媒平台（多选，列百分比）

三级标签	社媒平台					
	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
疫苗接种攻略	22.70%	0.00%	20.30%	39.90%	14.30%	0.00%
疫苗接种体验	50.70%	66.70%	40.50%	24.90%	28.60%	0.00%
疫苗接种后反应	49.70%	66.70%	44.00%	44.50%	28.60%	0.00%
疫苗选择建议	55.60%	0.00%	32.20%	39.90%	42.90%	0.00%
疫苗接种注意事项	42.20%	33.30%	22.50%	32.90%	0.00%	0.00%

小红书以疫苗选择建议（55.60%）、疫苗接种体验（50.70%）、疫苗接种后反应（49.70%）的高比例，成为全维度推荐分享的核心场域；

微博的分享集中于疫苗接种体验（66.70%）与疫苗接种后反应（66.70%），其他维度较少涉及，凸显其作为口碑扩散阵地的属性，适合传递直观的接种效果

与体验；

快手在疫苗接种攻略（39.90%）、疫苗选择建议（39.90%）上比例最高，契合其下沉市场用户对实操攻略与直接建议的需求；

抖音的各分享维度比例相对均衡但整体偏低，以疫苗接种后反应（44.00%）、疫苗接种体验（40.50%）为主，体现短视频平台“快速分享、广泛传播”的特征；

哔哩哔哩的分享集中于疫苗选择建议（42.90%）、疫苗接种体验（28.60%），内容量较少但契合其科普与实用建议的内容定位；

知乎在推荐分享各维度均无相关内容，推测其平台生态更侧重问答解惑，而非接种后的主动分享传播。

（三）社媒讨论空间分布

儿童 13 价肺炎疫苗在社交媒体的讨论呈现平台集中化与网络环境地域分布不均衡特征：抖音、小红书、微博占据核心讨论份额，且广东、北京、浙江等经济发达/人口大省贡献主要讨论量；而快手、哔哩哔哩、知乎的地域分布呈现“单点突破”态势。

表 60 推荐分享四级标签：社媒平台（多选，列百分比）

地域	小红书	微博	抖音	快手	哔哩哔哩	知乎
安徽	2.40%	2.90%	4.70%	1.70%	0.00%	0.30%
澳门	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%
北京	4.70%	9.70%	2.50%	3.00%	6.60%	92.50%
福建	2.20%	2.40%	2.70%	9.90%	0.70%	1.00%
甘肃	0.30%	0.70%	1.80%	1.20%	0.00%	0.00%
广东	10.20%	9.50%	11.30%	3.30%	4.40%	1.60%
广西	0.80%	1.30%	1.90%	1.00%	0.00%	0.00%
贵州	0.70%	0.70%	2.10%	1.20%	0.00%	0.00%
海南	0.40%	0.60%	1.20%	0.20%	0.00%	0.00%
河北	2.50%	3.90%	5.30%	5.00%	2.20%	0.00%
河南	3.40%	5.80%	8.00%	3.50%	2.90%	0.00%
黑龙江	0.60%	0.70%	1.10%	2.50%	0.00%	0.00%
湖北	2.50%	3.00%	3.90%	1.00%	0.00%	0.60%
湖南	1.80%	10.60%	3.70%	1.20%	0.00%	0.30%
吉林	0.50%	0.70%	1.00%	2.70%	0.00%	0.00%
江苏	4.50%	5.10%	4.90%	1.80%	8.00%	0.00%
江西	1.20%	1.50%	2.80%	0.40%	0.00%	0.00%

境外	0.80%	1.30%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%
辽宁	1.90%	2.60%	2.60%	4.40%	1.50%	0.00%
内蒙古	0.30%	0.60%	1.10%	1.50%	0.00%	0.00%
宁夏	0.10%	0.20%	0.30%	0.70%	0.00%	0.00%
青海	0.10%	0.30%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%
山东	4.10%	7.10%	6.60%	5.00%	0.70%	0.00%
山西	0.90%	2.10%	2.40%	2.70%	0.70%	0.00%
陕西	1.50%	1.80%	2.80%	0.80%	1.50%	0.00%
上海	4.60%	3.50%	2.70%	0.80%	2.90%	0.60%
四川	3.70%	4.20%	8.00%	1.80%	5.10%	0.60%
台湾	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%
天津	0.80%	1.80%	0.80%	0.80%	0.00%	0.00%
西藏	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
香港	0.30%	0.30%	0.10%	1.60%	0.70%	0.30%
新疆	0.30%	0.50%	0.70%	0.20%	0.00%	0.00%
云南	0.90%	1.20%	2.80%	2.10%	0.00%	0.30%
浙江	8.40%	5.30%	7.30%	1.20%	0.00%	0.60%
重庆	1.40%	2.50%	1.50%	0.80%	0.00%	0.30%

小红书/微博/抖音：核心市场高度一致，格局略有不同。广东、北京、上海、江苏、四川、山东等经济发达、人口密集的省份/直辖市，在三大平台（小红书、微博、抖音）的讨论占比均名列前茅。

知乎：高度集中于一线高知城市。北京以 92.5% 的绝对占比主导了知乎的讨论，其他地区声量微乎其微，这印证了知乎以一线城市、高学历、高收入用户为核心的生态。

快手：凸显区域特性与下沉市场。福建（9.9%）占比异常突出，远超其在全国声量中的常规水平。河北、山东、辽宁等北方省份占比也相对较高，显示出较强的区域文化或社群效应。

哔哩哔哩：集中于高线与高教区域。北京（6.6%）、江苏（8.0%）、四川（5.1%）占比较高，与其用户画像（年轻、学生、高线城市）吻合，讨论集中在高等教育资源丰富或互联网文化浓厚的地区，是接触年轻潜在父母或高知新手父母的细分窗口。

综上，从分析结果来看，地域关注度与平台用户生态高度绑定：关于 PCV13 疫苗的社媒讨论，其地域分布并非均匀扩散，而是与各平台的核心用户群体所在地高度重合。

（四）小结

基于对 PCV13 疫苗在社媒平台的内容分布、声量趋势、账号类型及地域特征的多维度分析，本章系统揭示了当前社媒生态中相关讨论的格局特征与运行逻辑。主要研究发现可归纳为以下四个方面：

1、平台生态呈现“双核驱动、功能互补”的梯次格局

社媒声量高度集中于小红书（46.71%）与抖音（34.34%），构成内容生态的“双核心”。其主贴类型均以科普知识、产品推荐、咨询讨论及个人体验为四大支柱，表明这两大平台是用户完成消费链路的核心生活场域。微博虽声量居第三（14.70%），但以其公共舆论场属性，在政策认知（69.50%）和热点引爆上发挥不可替代的声量放大器作用。而快手、知乎、B 站等平台受用户属性与话题匹配度限制，声量微弱（合计不足 5%），属于细分补充型渠道。

2、内容需求清晰分层，映射用户决策的不同阶段

社媒内容分布精准对应不同决策阶段的需求：

（1）认知启动期：科普知识类内容占比最高（46.05%），是市场教育的基石，为整个话题奠定理性基调。

（2）决策评估期：产品推荐（34.76%）与产品比较（18.85%）内容情感最为积极（情感值 0.18/0.17），表明用户进入深度决策时，对具体产品信息的关注度和满意度最高。

（3）信任构建期：个人体验分享（30.06%）与咨询讨论（32.71%）占据重要份额，是用户建立最终信心的关键环节，反映真实市场反馈。

这种分层结构表明，社媒内容生态由用户自发的、实用性的决策需求所驱动，是一个典型的“用户中心”内容市场。

3、社媒传播生态中“情感热力 Vs. 专业冷静”的二元结构，机遇风险并存，需有效应对

研究显示，素人用户声量比例为 86.19%，构成了内容生产的主体，这其中宝妈账号更为突出，关于 PCV 情感得分相对最高，表明宝妈对 PCV 疫苗态度最积极正面。相对而言，官方政务账号和医生账号主贴在情感表达上更为理性，情感得分仅 0.07。因此，宝妈账号的“情感热力”与官方/医生账号的“专业冷静”在社媒生态中形成了独特二元结构，这既是社媒内容营销的机遇，也暗藏风险。

一方面，宝妈账号凭借真实育儿场景和高度共情能力，能有效降低用户对疫苗的陌生感与焦虑感，是推动认知转化为行动的关键触点；而医生、政务等专业账号则提供科学依据与政策背书，增强信息可信度，抑制谣言扩散。但若缺乏专业引导，高情感内容容易滑向片面化甚至情绪化。例如，个别宝妈基于个体经验过度强调疫苗“万能”或“无风险”，可能误导其他家长形成非理性预期；而专业声音若长期缺席热点讨论，则会在关键时刻丧失话语权，导致公众在争议事件中转向非权威信源。

因此，宝妈账号和官方/医生账号二者形成联动，例如由医生参与宝妈发起的话题答疑、或企业联合 KOL 将专业指南转化为亲子对话脚本，可实现“可信内容的情感化表达”，构建“专业内核+情感外壳+社群扩散”的内容生产协作机制，就可以显著提升传播效能。

4、地域关注度与平台用户生态深度绑定，市场策略需精准分层

儿童 13 价肺炎疫苗在社交媒体的讨论呈现平台集中化与网络环境地域分布不均衡特征：抖音、小红书、微博占据核心讨论份额，且广东、北京、浙江等经济发达/人口大省贡献主要讨论量；而快手、哔哩哔哩、知乎的地域分布呈现“单点突破”态势。

五、本竞品口碑分析

（一）企业品牌声量

1、企业品牌声量比例

当前肺炎疫苗市场的网络声量高度集中于**沃森品牌**。沃森品牌以 79.10% 的占比遥遥领先于其他品牌，远超第二名民海品牌（53.80%）。这表明沃森品牌在公众讨论、媒体报道或网络舆论中的曝光度极高。

表 61 疫苗企业品牌在全网的声量分布（列百分比）

企业品牌	计数	比例
康希诺品牌	14177	33.80%
沃森品牌	33136	79.10%
辉瑞品牌	18989	45.30%
民海品牌	22533	53.80%

但具体观察沃森品牌口碑数据，发现存在社交媒体账号内容突出沃森产品优势的同时，通过对比方式贬低其他品牌，存在“拉踩”竞品行为，以达到营销目的，以下为某抖音账号，共发布 8 个作品均聚焦 PCV13 疫苗，且内容高度集中、账号运营模式单一，疑似为沃森定向营销目的创建，因此，沃森品牌声量过高存在水军嫌疑。



图 5 存在“拉踩”竞品行为的疑似沃森品牌水军样例截图



图 6 存在“拉踩”行为的疑似沃森品牌水军作者主页

网址链接：<https://www.douyin.com/note/7549054927009172793>

2、企业品牌声量在不同媒介类型中的表现

小红书已成为肺炎疫苗品牌传播的**核心战场**，几乎所有品牌的声量都高度集中于此。

表 62 疫苗企业品牌在不同平台中的声量分布（列百分比）

社媒平台	企业品牌声量			
	康希诺	沃森	辉瑞	民海
小红书	52.10%	70.60%	70.20%	75.70%
微博	30.00%	9.00%	10.70%	3.50%
抖音	13.90%	18.40%	16.50%	18.60%
快手	1.40%	1.30%	0.90%	1.90%
哔哩哔哩	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%
知乎	2.50%	0.70%	1.60%	0.30%

康希诺品牌：小红书（52.10%）和微博（30.00%）是两大主阵地，抖音（13.90%）也有一定声量，整体看来传播**更为均衡**。

沃森品牌：声量高度集中于小红书（70.60%），其次为抖音（18.40%）、微博（9.00%），显示出沃森品牌声量更加**集中于小红书**这种生活方式类的平台。

辉瑞品牌：小红书占比最高（70.20%），抖音（16.50%）和微博（10.70%）次之，辉瑞品牌的整体表现与沃森相似，都是**集中于小红书**这种生活方式类平台。

民海品牌：民海在小红书占比高达 75.70%，远超其他平台，抖音（18.60%）为次要渠道。**民海为四家疫苗品牌中最依赖小红的品牌**，几乎将全部声量集中在该平台。

综上，社媒传播整体呈现“**小红书为主力、微博及抖音为补充**”的格局，不同品牌在社媒分布上呈现差异化定位，从数据可见，小红书在所有平台中占比最高，其中民海（75.70%）、沃森（70.60%）、辉瑞（70.20%）和康希诺（52.10%）均在此平台占据主导声量。这表明小红书已成为疫苗企业进行品牌宣传、消费者进行品牌讨论的重要渠道。

3、企业品牌声量在不同主贴类型中的表现

四家疫苗企业均在科普知识类这一主贴类型下的占比最高，说明**科普内容是各品牌的核心声量场景**。

表 63 疫苗企业品牌在不同主贴类型中的声量分布（列百分比）

主贴类型	企业品牌声量			
	康希诺	沃森	辉瑞	民海
科普知识类	40.90%	44.80%	44.40%	45.80%
个人体验分享	30.70%	30.30%	31.20%	29.90%
咨询讨论类	33.30%	33.50%	36.30%	37.80%
产品推荐类	33.80%	37.30%	35.50%	37.10%
产品比较类	22.40%	22.10%	24.30%	23.90%
政策宣传类	10.30%	6.00%	6.70%	6.50%
广告宣传类	8.50%	8.00%	7.40%	7.90%

横向比较看，四大品牌在用户讨论中形成了不同的锚点，**民海**锚定在“**决策前的广泛比较与推荐**”，**沃森**锚定在“**实用推荐**”，**辉瑞**锚定在“**均衡的用户讨论与体验**”，**康希诺**则锚定在“**政策关联与权威形象**”。这种差异构成了当前市场品牌认知的基本格局。

4、企业品牌声量在不同账号类型中的表现

康希诺、沃森、辉瑞、民海四大疫苗品牌在社交媒体上的声量主要由普通账号与素人账号主导，其中素人账号占比最高（76.50%-92.80%），KOL 账号次之（1.60%-17.30%），官方及机构类账号影响力有限，反映出用户生成内容（UGC）是当前 PCV13 疫苗品牌传播的核心驱动力。

表 64 疫苗企业品牌在不同账号角色中的声量分布（列百分比）

账号角色	企业品牌声量			
	康希诺	沃森	辉瑞	民海
官方政务账号	0.70%	0.20%	0.10%	0.10%

机构/企业账号	2.20%	1.10%	1.10%	0.80%
医生账号	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
媒体账号	2.60%	0.70%	0.70%	0.20%
专业人士账号	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%
KOL 账号	17.30%	5.40%	4.30%	1.60%
普通账号	6.20%	3.60%	5.40%	5.60%
素人账号	76.50%	91.10%	90.30%	92.80%
宝妈账号	5.10%	5.60%	6.40%	6.50%
宝爸账号	0.80%	0.50%	0.60%	0.90%

康希诺：声量结构独特，在 KOL 和媒体中讨论量显著。康希诺在 KOL 账号中的声量占比高达 17.30%，横向高于其他品牌（沃森 5.40%，辉瑞 4.30%，民海 1.60%）。在媒体账号中，康希诺声量占比 2.60%，也显著高于其他品牌。结合其在“官方政务账号”和“机构/企业账号”的占比也均为最高，可以看出康希诺的品牌叙事与官方、机构及媒体频道的关联性更强。

沃森：声量高度依赖素人，其他角色参与度均衡偏低。沃森在素人账号中的声量占比高达 91.10%，仅次于民海。这意味着其品牌声量几乎完全由普通用户的自发讨论所支撑。在 KOL、媒体、机构/企业、官方政务等所有具备潜在影响力的账号角色中，沃森的声量占比均处于中低水平。

辉瑞：素人主导下，普通用户与宝妈讨论更活跃。辉瑞在素人账号的声量占比为 90.30%，与沃森、民海同处第一梯队。在“宝妈账号”这一精准垂直人群中，其占比 6.40%，是四个品牌中最高的。这表明辉瑞在具有直接消费决策权的“宝妈”群体中，讨论热度相对领先，用户基础良好。

民海：极致的素人依赖型，垂直影响力介入最浅。民海在素人账号的声量占比达到 92.80%，为四品牌中最高。其品牌舆论场几乎完全由普通大众构成。在媒体账号（0.20%）和 KOL 账号（1.60%）中，民海的声量占比均为最低。

综上所述，当前疫苗品牌声量结构分化为两种模式：一是以沃森、辉瑞、民海为代表的“素人绝对主导型”，其声量 90%以上来源于大众自传播；二是以康希诺为代表的“多元影响驱动型”，其声量中 KOL 和媒体等角色的贡献显著，结构更为多元。

就康希诺单独来看，其在 KOL 和媒体端的高占比，使其品牌具备更强的议题设置潜力和舆论放大能力。然而，这也意味着其声量更易受到少数关键节点的影响，且素人自发讨论的占比相对较低，需关注品牌口碑在广大普通用户中

的真实、稳定与健康度。如何将 KOL/媒体的影响力有效转化为更广泛的素人口碑，是其传播链路中的关键课题。

（二）产品品牌声量

1、产品品牌声量比例

产品品牌声量呈现“一超一强，两翼跟随”的竞争格局。沃安欣（52.20%）与沛儿 13（39.00%）形成了显著的讨论话题量。维民菲宝与优佩欣作为“跟随者”，声量空间相对压缩，在舆论场中比例相对较低。

表 65 疫苗产品品牌在全网的声量分布（列百分比）

产品品牌	计数	比例
优佩欣品牌	1433	20.20%
沃安欣品牌	3695	52.20%
沛儿 13 品牌	2764	39.00%
维民菲宝品牌	1594	22.50%

2、产品品牌声量在不同媒介类型中的表现

各品牌平台策略分野清晰，形成“单点突破”与“双核驱动”两种模式，沃安欣、沛儿 13、维民菲宝均呈现高度聚焦小红书的“单点突破”模式，将小红书作为近乎唯一的声量引擎。而优佩欣则呈现“小红书+微博”的双核驱动模式，声量结构更为分散和均衡。

表 66 疫苗产品品牌在不同平台中的声量分布（列百分比）

社媒平台	产品品牌声量			
	优佩欣	沃安欣	沛儿 13	维民菲宝
小红书	44.90%	74.90%	75.80%	78.40%
微博	28.60%	3.40%	6.30%	3.40%
抖音	18.40%	20.10%	15.90%	15.30%
快手	2.00%	1.20%	1.40%	2.70%
哔哩哔哩	2.00%	0.10%	0.20%	0.00%
知乎	4.10%	0.20%	0.40%	0.10%

优佩欣：双核驱动，结构相对均衡。优佩欣在社媒平台中的声量呈现“小红书+微博”双核心驱动的声音结构。在小红书（44.90%）保持主流存在的同时，其在微博（28.60%）的声量占比显著高于其他所有竞品，构成了独特的第二支柱。

沃安欣：高度聚焦，依赖核心阵地。沃安欣呈现“小红书主导型”的极集中式分布。其 74.90% 的声量集中于小红书，而在微博（3.40%）、快手（1.20%）、B 站（0.10%）和知乎（0.20%）的声量均处于极低水平。

沛儿 13：核心聚焦，全域存在感偏弱。与沃安欣类似，同属“小红书绝对主导型”，其 75.80% 的声量来自小红书。在其他所有平台（微博 6.30%，抖音 15.90%，其他均低于 1.5%）的声量占比也普遍偏低。作为国际品牌，沛儿 13 的声量结构显示出它对本土化社交媒体生态的适应同样选择了聚焦策略，但其在小红书外的声量基础略优于沃安欣。

维民菲宝：极端集中，风险与效率并存。在所有品牌中呈现出“最极端的平台集中度”，高达 78.40% 的声量来自于小红书，其他平台占比总和仅为 21.6%。

3、产品品牌声量在不同主贴类型中的表现

品牌在用户决策链条中扮演不同角色。从数据可推断用户讨论的潜在路径：沃安欣/沛儿 13/维民菲宝常作为科普的“知识起点”和咨询的“基准选项”；维民菲宝则在咨询环节作为关键的“比较对象”被高频提及；优佩欣更多出现在咨询讨论和产品推荐中。

表 67 疫苗产品品牌在不同主贴中的声量分布（列百分比）

主贴类型	产品品牌声量			
	优佩欣	沃安欣	沛儿 13	维民菲宝
科普知识类	23.70%	45.20%	47.00%	47.60%
个人体验分享	28.90%	28.50%	29.20%	27.60%
咨询讨论类	31.60%	36.40%	37.00%	39.40%
产品推荐类	34.20%	39.40%	38.10%	39.40%
产品比较类	26.30%	23.20%	26.80%	26.40%
政策宣传类	7.90%	4.30%	6.10%	6.40%
广告宣传类	0.00%	8.60%	7.00%	7.10%

综上所述，科普、咨询与产品推荐是品牌占领用户心智的战场，格局已初步固化：在科普知识类、咨询讨论类和产品推荐类这三大类构建认知的主贴类型中，沃安欣、沛儿 13、维民菲宝形成了声量上的“第一梯队”，且彼此差距微小。而优佩欣在这两个阵地的声量显著落后。**体验分享与政策讨论呈“低差异”与“低关注”特征：**所有品牌在个人体验分享中的声量分布极为接近

（27.6%-29.2%），说明接种后分享行为对品牌无显著偏好。同时，所有品牌在

政策宣传类声量均很低（<8%），表明疫苗相关的政策话题并非当前公众讨论的主流。

4、产品品牌声量在不同账号类型中的表现

品牌声量结构呈现两种传播模式：一是以优佩欣为代表的“素人+KOL 深度影响型”，其声量受素人和 KOL 中心化节点显著驱动；二是以沃安欣、沛儿 13、维民菲宝为代表的“素人绝对主导型”，其声量几乎全部来自大众自传播。这反映出各品牌在舆论场中的“引爆点”和信任链存在根本差异。

表 68 疫苗产品品牌在不同账号中的声量分布（列百分比）

账号角色	产品品牌声量			
	优佩欣	沃安欣	沛儿 13	维民菲宝
官方政务账号	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%
机构/企业账号	4.10%	0.80%	0.80%	1.00%
医生账号	0.00%	0.10%	0.40%	0.10%
媒体账号	4.10%	0.50%	0.80%	0.60%
专业人士账号	2.00%	0.20%	0.20%	0.30%
KOL 账号	30.60%	6.50%	3.20%	2.80%
普通账号	12.20%	5.30%	4.70%	4.20%
素人账号	57.10%	88.20%	92.10%	93.00%
宝妈账号	2.00%	5.30%	8.30%	6.70%
宝爸账号	6.10%	0.70%	1.10%	1.20%

优佩欣：素人+KOL 驱动型声量结构。其声量结构在所有品牌中最为独特。KOL 账号贡献了 30.60%的声量，占比远超其他品牌，且在所有账号类型中仅次于素人账号。同时，其在官方政务、机构/企业、媒体账号的占比（均为 4.10%）也相对突出。这表明优佩欣的舆论场受关键意见领袖的深度影响和塑造。KOL 的高比例介入，意味着其品牌话题更易引发或受控于有影响力的节点。较高的官方/媒体账号占比，则反映了其在权威信息场中拥有相对较高的能见度。

沃安欣：典型的素人口碑驱动模式。素人账号声量占比高达 88.20%，为所有品牌中第二高，构成了其声量的绝对基石。其他所有类型账号的声量占比均很低（最高为 KOL 的 6.50%）。沃安欣的声量几乎完全由普通用户的讨论所支撑，呈现出典型的“群众口碑”型传播结构。其舆论场受 KOL、媒体等“中心化”节点的影响较小，品牌认知的构建更依赖于大量用户的真实体验与相互推荐，舆论基础看似分散但体量庞大。

沛儿 13 与维民菲宝：高度集中的素人讨论场。两者声量结构高度相似，均表现出极致的素人依赖。维民菲宝的素人账号占比达 93.00%，沛儿 13 也 92.10%，均为各类型中最高。其他角色账号的声量贡献微乎其微。这两个品牌的舆论场最为“去中心化”，其讨论几乎完全沉淀在广大普通用户中。尤其是维民菲宝，其声量来源最为纯粹和集中。这反映出它们的品牌讨论更接近于一种“民间自发议题”，较少被 KOL 或权威媒体设置议程或深度介入。宝妈账号在沛儿 13（8.30%）的占比相对较高，显示其在核心消费群体中有一定的讨论集中度。

（三）企业品牌负面口碑分析

本章进行的本竞品分析，是通过疫苗企业品牌和产品品牌为关键词进行全网采集开展相关分析，有效数据量为 37,218 条。考虑企业可能通过软文、水军等方式进行宣传，本节进一步选择品牌负面口碑进行分析，有效数据为 1656 条，从而了解本竞品更真实问题痛点，为品牌优化提供具体真实改进方向。

1、企业品牌负面口碑总体情况

根据负面口碑来源，将涉及负面情感讨论的平台依据其属性特征划分为以下两类：（1）**媒体平台**，为品牌方、政府、权威媒体、券商、研究机构官方网站；（2）**社媒平台**。包括小红书、微博、抖音、快手、知乎、B 站等。

通过对本竞品负面口碑主题分析，各企业负面口碑特点汇总如下表所示。

表 69 企业品牌负面口碑特点

序号	品牌	负面口碑特点
1	辉瑞	- 不良反应是最突出的问题，消费者对接种后副作用的担忧非常强烈 - 价格敏感度高，用户普遍认为辉瑞疫苗价格过高 - 社媒平台负面情绪集中，显示出用户对进口疫苗期望值与实际体验的落差 - 与国产疫苗的比较频繁，反映出市场竞争激烈
2	沃森	- 媒体平台关注度极高，尤其是在公司财务状况、应收账款管理和业绩表现方面 - 社媒平台上的负面情绪主要集中在接种不良反应和品牌比较上 - 财务相关负面报道占比最高，显示资本市场对沃森的担忧 - 负面情感总量最大，品牌声誉面临较大挑战
3	民海	- 临床试验设计质疑是最大负面因素，消费者关注研究方法的科学性 - 对疫苗安全性的担忧较为突出 - 与其它品牌的比较中处于劣势，品牌形象有待提升 - 双载体技术等创新技术受到质疑，需加强科普宣传 - 媒体渠道负面信息极少，显示专业媒体对此品牌关注度较低

4	康希诺	- 消费者对接种后不良反应的关注度高，主要担心发热、哭闹、腹泻、红疹等问题 - 价格敏感性明显，用户普遍关心疫苗的性价比 - 社媒平台成为负面情绪的主要宣泄渠道，传播范围广但影响较为分散
---	-----	---

2、辉瑞负面口碑分析

（1）总体情况

辉瑞品牌的负面口碑主要集中在社媒平台上负面口碑内容上，接种不良反应和价格问题是两大核心关注点。不良反应话题占据近半数比例，价格较高也是用户普遍反映的问题。这表明消费者对进口疫苗的安全性和性价比存在疑虑。

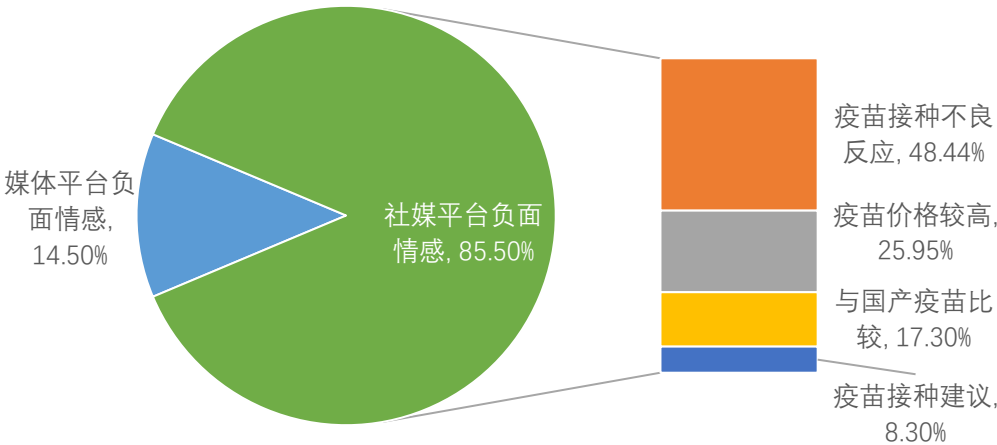


图 7 辉瑞品牌负面渠道分布及情感主题分析

（2）社媒平台负面口碑分析

从社媒平台的负面口碑具体内容来看，“疫苗接种不良反应”主题以48.44%的绝对占比成为负面情绪的焦点。近一半的负面讨论围绕接种后的发热、哭闹、过敏等反应展开。下表中的示例特别提及“针头较长”等产品物理特性，加剧了家长的恐惧与负面联想。“疫苗价格较高”主题占比25.95%，是第二大负面来源。在示例中，用户明确将辉瑞700多元的单针价格与国产400多元的价格对比，并质疑其“性价比”，这表明，在经济环境和消费观念变化的背景下，其高端定价策略面临挑战。

表 70 社媒平台的辉瑞负面口碑分析

问题分类	主题描述	比例	示例
疫苗接种 不良反应	接种后出现发 热、哭闹、过敏 等不良反应	48.44%	“辉瑞 13 价第一种是辉瑞，价格 700 多，美国进口疫苗，但是很多妈妈反映接种完后发热较多，宝宝哭闹厉害，后面听医生说针头较长，宝宝打针时候哇哇哭”
疫苗价格 较高	认为辉瑞疫苗价 格过高，性价比 不高	25.95%	“进口辉瑞沛儿单载体 700 多一针，但是普遍反映发热较多，小月龄孩子发热还容易会引起惊厥，现在这种就医环境，还是谨慎选择！国产民海的双载体 400 多一针，是第二代肺炎，某红书上刷了很多，总结下来，双载体工艺更先进，保护效果和安全性都好于单载体，并且价格也更适合疫情之后的消费观念 所以本报告是果断选择了北京民海的双载体 13 价肺炎疫苗”
与国产疫 苗比较	与国产疫苗在效 果、价格、安全 性方面的比较	17.30%	“宝宝年前就应该打 13 价了，当时决定打进口辉瑞的，主要是因为他的上市时间稍长。[皱眉 R] 由于年前事情太多了，庆幸没来得及去打疫苗，年后来到卫生院，最终选择的是玉溪沃森的 13 价。原因主要有三点：[派对 R]1、不盲目信任品牌。受“哪吒”电影的启示，我便多方比较了一下两个产品的区别。玉溪沃森的 13 价是全球第 2 个上市的，上市后安全性数据显示，不良反应更少。制备工艺也更先进，血清型的抗体水平也是优于美国的。[赞 R]2、玉溪沃森使用的是中国的菌株，辉瑞的是使用的是美国的菌株。从基因学上来讲，我认为中国的菌株会更适合中国人。[色色 R]沃森的产品宣传语我也看到是“更适合中国宝宝的 13 价肺炎结合疫苗”。[偷笑 R]3、在小红书上看到说辉瑞的针头比较长，可能是由于国外宝宝比较壮的原因，虽然出口到中国，但是也没有考虑中国宝宝体质。玉溪沃森的针头就比较短，对中国宝宝更友好。”
疫苗接种 建议	关于是否选择辉 瑞疫苗的咨询和 建议	8.30%	“当妈太难了，每天都在做选择题…尤其是疫苗，本来是想十三价能预防降低肺炎、脑膜炎风险才打的，现在打了两针，辉瑞跟我说这是... 怎么办啊，你们的娃打了没？”

（3）媒体平台的负面口碑分析

从媒体平台的负面口碑具体内容来看，主要分布在以下三个方面：

- 疫苗市场表现（占比约 51.02%）：对辉瑞疫苗全球销售下滑、市场份额下降的报道；

– 疫苗行业整体环境（占比约 30.61%）：媒体对疫苗行业整体市场环境的分析和报道；

– 疫苗产品竞争分析（占比约 18.37%）：对辉瑞疫苗在市场竞争中的地位和策略的分析；

“疫苗市场表现”以超半数（51.02%）的占比成为媒体最集中的负面议题，主要关注其全球销售下滑与市场份额流失。这表明，在媒体叙事中，辉瑞正面临严峻的市场增长乏力和竞争优势被侵蚀的挑战，这与其在社交端因“价格较高”被诟病形成呼应，共同指向其市场定位与商业模式的可持续性正承受内外双重压力。

综上所述，辉瑞负面情感数据量较大，以不良反应和价格较高为主，媒体渠道负面涉及市场表现。另外，无论在媒体端的“产品竞争分析”（18.37%）中，还是在社交端高达 17.30%的“与国产疫苗比较”中，国产疫苗（如沃森、民海）都被明确视为核心参照系和挑战者。用户则从效果、价格、安全性甚至文化适应性（如“更适合中国宝宝”）进行具体对比，从社媒用户讨论中，国产疫苗的崛起已对辉瑞构成系统性、多维度的竞争压力，而不仅是局部市场的价格挑战。

3、沃森负面口碑分析

（1）总体情况

沃森品牌的负面情感数据量排第二，且社媒及官方渠道占比均较高，说明该品牌受到了较多的媒体关注和报道，特别是对公司财务状况和业绩表现的负面评价。社媒平台上主要关注接种后的不良反应及与其他品牌的比较。这反映出沃森品牌在资本市场面临较大压力，同时在消费者层面也存在一定的信任问题。

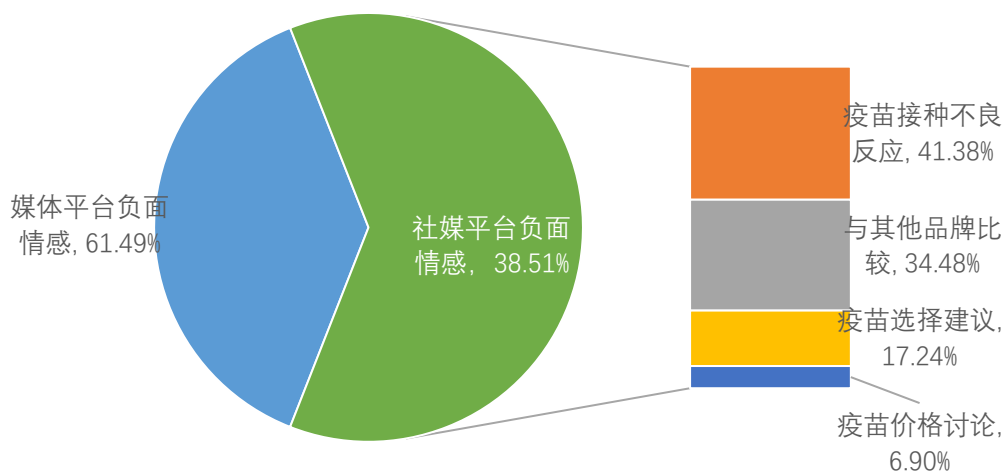


图 8 沃森品牌负面渠道分布及情感主题分析

（2）社媒平台负面口碑分析

从社媒平台的负面口碑具体内容来看，不良反应仍是用户负面情绪的绝对主导。沃森在社媒平台的负面情感呈现出清晰的二元结构，约四成源于产品使用后的直接体验（不良反应），另约四成则源于市场中的被动比较（与辉瑞、民海等）。这表明沃森这一品牌同时面临着用户体验优化和市场竞争定位的双重压力。

表 71 沃森负面情感在社媒平台的主题分析

问题分类	主题描述	比例	示例
疫苗接种不良反应	接种后出现发热、哭闹、食欲不振等不良反应	41.38%	“选的“沃森”，说反应最小。但是娃还是从昨晚 12 点睡到今天下午 13 点，算是勉强睡醒了。早上看还有小眼袋，像是熬了个大夜一样 藍。平时能干 150-160ml 奶，昨晚就吃 100ml 就不要了，感觉已经困的不行，很烦躁。打针的地方也有个小肿块，红红的。所以我在想，之前说 13 价+5 价口轮副作用很大的，是不是主要因为 13 价太猛了？”
与其他品牌比较	与辉瑞、民海等品牌的效果、价格比较	34.48%	“在价格方面，民海 13 价在三家里最为亲民，民海 458，对比沃森的 598，辉瑞的 698，简直不要太香！所预防的肺炎球菌血清型都是一

			样，双载体工艺更为先进，但价格更亲民。”
疫苗选择建议	关于是否选择沃森疫苗的咨询和建议	17.24%	“而沃森和北京民海对比，北京民海属于双载体 13 价，沃森 13 价属于单载体疫苗。而接种含白喉类毒素或破伤风类毒素的单载体肺炎疫苗，会降低其他同时期接种的疫苗的抗原水平，但接种双载体就不会有这个困扰。并且民海双载体 13 价是惟一具有国内人群长期免疫持久性数据的 13 价疫苗，所有血清型保护性抗体至少可以持续 5 年以上”
疫苗价格讨论	对沃森疫苗价格的讨论和质疑	6.90%	“**价格对比**： 进口辉瑞：700+元（单载体） 国产沃森：600+元（单载体） 国产民海：400+元（双载体，性价比之王）”

（3）媒体平台的负面口碑分析

从媒体平台的负面口碑具体内容来看，主要分布在以下四个方面：

- 公司财务状况（占比约 43.20%）：对沃森生物应收账款管理、财务风险的分析和质疑；
- 疫苗行业市场环境（占比约 32.40%）：媒体对疫苗行业整体市场环境的分析和报道；
- 公司业绩与股价表现（占比约 17.28%）：对沃森生物业绩下滑、股价下跌的分析和报道；
- 疫苗产品销售与竞争（占比约 7.13%）：对沃森疫苗产品销售情况、市场竞争地位的分析和质疑；

在四个疫苗企业的负面情感中，沃森生物呈现出独特的渠道分布结构：其超过六成（61.49%）的负面讨论来源于媒体渠道，这一比例远高于同行业其他品牌（康希诺 18.92%、辉瑞 14.50%、民海 3.96%），显示出媒体舆论场是沃森当前面临负面压力的主要来源。沃森生物在媒体渠道的负面关注点高度集中于其作为上市公司的经营基本面与宏观环境，具体来看，超过 92%的媒体负面讨

论围绕公司财务、业绩及行业环境展开，这指向了来自投资者、分析师及行业观察者的审视视角。

综上所述，沃森的负面情感数据量最大，媒体渠道负面占比最高，主要涉及财务状况和业绩表现。

4、民海负面口碑分析

(1) 总体情况

民海品牌的负面口碑几乎全部来自社媒平台，主要集中在对临床试验设计和疫苗安全性的质疑。这反映出消费者对疫苗研发过程的科学性和严谨性有较高要求，同时对新技术路线（如双载体技术）存在一定的不信任感。

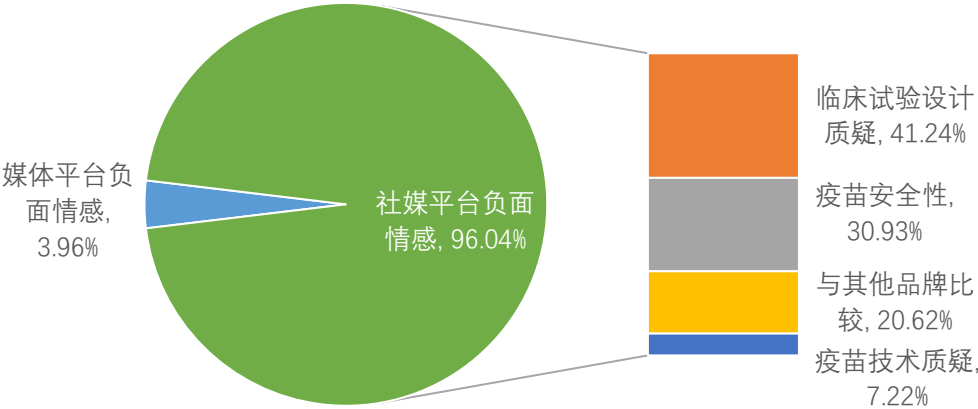


图 9 民海品牌负面渠道分布及情感主题分析

(2) 社媒平台负面口碑分析

从社媒平台的负面口碑具体内容来看，负面声量高度集中于产品的“科学信誉”与“数据资产”短板：高达 72.17%的负面讨论（临床试验质疑 41.24% + 安全性 30.93%）直指民海疫苗的临床数据完备性和长期安全证据。这表明，作为市场后来者，其面临的最大挑战是证明自身产品与成熟竞品具备同等坚实的科学基础，而不仅仅是价格或可及性。

表 72 民海负面情感在社媒平台的主题分析

问题分类	主题描述	比例	示例
临床试验设计质疑	对民海疫苗临床试验设计、对照选择的质疑	41.24%	“而民海是以辉瑞 13 价为对照上市的，相当于在稍低的标准上做对比，且临床数据仅覆盖 2-6 月龄的阳性对照，7 月龄后没有阳性对照数据，仅用 HIB 疫苗做阴性对照（这种试验设计在疫苗领域非常少见，上市略显仓促）” “作为上市时间最短的，总感觉临床有效数据积累得少一些，而且它是唯一采用双载体技术的，出于对新技术的谨慎，我还是选择了观望。”
疫苗安全性	对民海疫苗安全性、不良反应的质疑	30.93%	“目前国产的有两种，一种是玉溪沃森，一种是北京民海，两种上市的时间都不长，都还没有真实世界数据，打在宝宝·身上，还得慎重考虑，毕竟小宝宝各方面发育还不完善，听医生说进口的全球在用，使用时间久，品质有保证，安全性有效性都是有实实在在的数据的支撑，最终我给我宝宝接种了进口的。”
与其他品牌比较	与辉瑞、沃森等品牌的比较，认为民海疫苗不如其他品牌	20.62%	“先说结论：如果你家宝宝要打 13 价肺炎，辉瑞或沃森选一款都不会错，民海真的就算了。”
疫苗技术质疑	对民海疫苗双载体技术效果的质疑	7.22%	“民海是双载体，载体太复杂，我也搞不懂，但是对应适应症中就说明问题了，用哪种载体就有这种载体的禁忌症，所以辉瑞和沃森就各只有一种禁忌症，但是选民海就要注意了，因为是双载体，所以就是两种禁忌症，相应的风险就大一倍。”

（3）社媒平台的负面口碑分析

从媒体平台的负面口碑具体内容来看，主要分布在以下三个方面：

- 公司业绩与财务状况（占比约 50.00%）：对民海所属公司康泰生物业绩下滑、财务状况的分析和报道；
- 疫苗产品销售与竞争（占比约 25.00%）：对民海疫苗产品销售情况、市场竞争地位的分析和报道；
- 疫苗临床试验与技术（占比约 25.00%）：对民海疫苗临床试验设计、技术路线的分析和质疑；

综上所述，民海的负面口碑数据量相对较少，以临床试验设计质疑和安全性为主。

5、康希诺负面口碑分析

（1）总体情况

康希诺品牌的负面口碑主要来自媒体为主，负面口碑集中于**消费者对其疫苗接种后不良反应的担忧**，以及与其他品牌在价格和效果方面的比较。这反映了消费者对疫苗安全性的高度关注，以及对疫苗性价比的考量。

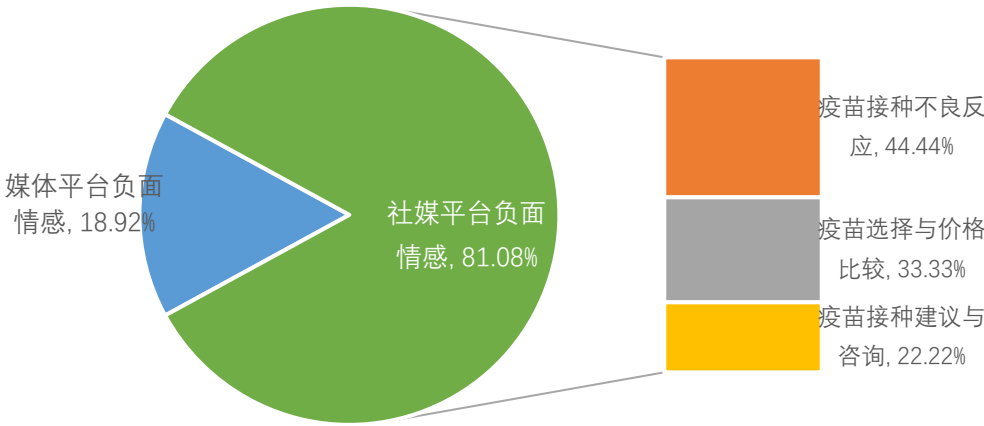


图 10 康希诺品牌负面渠道分布及情感主题分析

（2）社媒平台负面口碑分析

从社媒平台的负面口碑具体内容来看，“疫苗接种不良反应”以 44.44% 的占比，构成了康希诺在社媒平台上负面情感声量的绝对主体（近一半），是当前品牌面临的最突出、最集中的口碑风险。

表 73 康希诺负面情感在社媒平台的主题分析

问题分类	主题描述	比例	示例
疫苗接种不良 反应	接种流脑疫苗 后出现发热、 哭闹、腹泻、 红疹等不良反 应	44.44%	“我家宝宝于 2024.12.05 接种了康希诺流脑疫苗与乙肝疫苗 12 月下旬开始哭闹不止晚上更是睡不好觉 需要抱着入睡一次在换尿不湿时 发现腹股沟有个包块医院就诊后发现是腹股沟蜂窝 并且炎症累及导致隐睾在网上看到病例。疾控中心工作人员说 现在已经改进了方式 所以不太会有可能蜂窝织炎有懂行的朋友看看嘛！” “流脑 acyw135 康希诺我很多话想说***8 月 22 号打的流脑，当天晚上就频繁醒且大哭，必须抱起来才能继续入睡，频次大概一两个小时一次。8 月 23 号一天大便五次，打疫苗之前本报告一天一次或者两天一次，夜里大哭着醒来十几次，每次都要抱抱才能继续入睡。”
疫苗选择与价 格比较	与其他品牌疫 苗的价格、效 果比较，认为 康希诺性价比 不高	33.33%	“之前一直纠结要不要换 400 多康希诺的结合，做了好多攻略，有的省份说小月龄打了 AC 结合就不能打康希诺，有的说 6 岁那针万一 3 年后没扩龄咋办，有的说康希诺强势没多久红薯里好多广告，有的说效果都是 4 价，保护期都是到 9 岁多选绿竹性价比高。”
疫苗接种建议 与咨询	关于疫苗接种 时间、间隔、 安全性的咨询 和讨论	22.22%	“一起来看看区别吧！#康希诺流脑 #宝宝打疫苗 #ACYW 流脑结合 #自费疫苗 #育儿自费打流脑疫苗人傻钱多？” “流脑多糖结合疫苗有毒吗？！****我家敏宝！之前打脊灰百白破啥的，说糖丸不能吃让改了五联都没反应。但是打了这个多糖结合疫苗就起红疹了！#国药准字 S20210054acyw135 曼海 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合流脑多糖结合疫苗复溶后每瓶 0.5ml（详见说明书）有毒吗？！康希诺生物股份公司 CanSino Biologics Inc.”

（3）媒体平台的负面口碑分析

从负面主题在媒体平台的具体内容来看，主要分布在以下三个方面：

- 疫苗行业市场环境（占比约 47.62%）：媒体对疫苗行业整体市场环境的分析和报道；
- 公司业绩与财务状况（占比约 33.33%）：对康希诺业绩下滑、财务状况的分析和报道；

- 疫苗研发与产品管线（占比约 19.05%）：对康希诺疫苗研发进展、产品管线的分析和报道；

媒体平台中近半数（47.62%）的负面报道围绕整个疫苗行业的市场环境，约三分之一（33.33%）聚焦于公司自身的业绩与财务状况。这两者合计占比超过 80%，构成了媒体负面声量的绝对主体。

综上所述，康希诺负面情感分布特点主要集中在社媒平台，以不良反应为主，媒体渠道负面涉及行业环境和公司业绩。

（四）产品负面口碑分析

在本报告采集数据中，涉及产品的负面口碑数据量有限，其中**沛儿 13 为 119 条、沃安欣为 33 条、维民菲宝为 9 条、优佩欣为 0 条**。本报告通过上述产品负面口碑内容分析，了解各产品品牌的主要负面主题及典型表现。

1、沛儿 13 负面口碑分析

作为进口品牌，沛儿 13 的负面声量集中体现了其高价格承诺与不尽人意的接种体验（尤其是不良反应）之间的巨大落差。

主要负面口碑 1：不良反应高频提及。在社媒平台，关于接种后出现发烧、湿疹、嗜睡等不良反应的亲身分享占比最高，容易动摇其作为国际品牌应有的“安全、可靠”认知。例如：“好不容易治好的湿疹打完辉瑞又起来了，体重也不涨了[笑哭 R]”

主要负面口碑 2：价格过高。在高不良反应声量的背景下，高昂的价格容易激化了用户“不值”的感受，为国产疫苗的“性价比”叙事提供了空间。

“13 价肺炎疫苗！之前只知道进口“沛儿 13”，但价格贵还得抢！关键超过 15 月龄就不能打了！”

2、沃安欣负面口碑分析

舆论场中对沃安欣的负面认知，已从单纯的产品比较，上升至对其技术路线竞争力和母公司财务健康度的连锁性质疑。

主要负面口碑 1：技术优势在对比中被削弱。在社媒平台，当沃安欣（单载体）与双载体疫苗被同时提及讨论时，其技术路线常被置于劣势地位，引发“不值一提”、“直接 PASS”等负面评价。例如：“国产沃安欣单载体 600 多一针，研究了它的说明书，数据不值一提，直接 PASS 掉”

主要负面口碑 2：母公司财务状况加剧品牌信任危机。媒体频繁报道其母公司沃森生物“扣非净利暴跌八成、营收七连降”等财务问题，这类报道虽指向公司层面，但极易与核心产品“沃安欣竞争加剧”的议题关联，削弱市场对品牌持续竞争力的信心。例如：“扣非净利暴跌八成、营收七连降，沃森生物核心产品竞争加剧”

3、维民菲宝负面口碑分析

维民菲宝的负面口碑数量相对较少，这也与其整体声量不高有一定关系。通过负面口碑分析，主要集中在不良反应较明显、临近效期疫苗被使用等方面。

主要负面口碑 1：不良反应强度超出预期，引发家长焦虑。用户普遍将维民菲宝与其他常规疫苗（如麻腮风）对比，认为其局部反应（红肿、硬结）和全身反应（哭闹、发热）更剧烈，超出心理预期，进而对疫苗安全性产生怀疑。例如：“麻腮风也没有这么反应啊，13 价肺炎疫苗也太厉害了！红肿硬块、哭闹……有什么好办法缓解吗？”

主要负面口碑 2：疫苗有效期临近，接种信任受损。尽管法规允许在有效期内使用疫苗，但家长对“快过期”产品天然敏感。当接种点未主动更换或充分解释时，易被解读为“用临期库存”，损害品牌与接种机构的公信力。例如：“今天去打 13 价，有效期是 23 年到 25 年 5 月 25 日的，都快过期了……现在越想越担心，好后悔当时没强硬点让换一支。”

（五）小结

1、整体竞争格局：声量高度集中，传播模式分化

当前 PCV13 舆论场由沃森以 79.10% 的绝对声量主导，且整体呈现“素人绝对主导型”传播特征，但其高声量存在“拉踩”竞品、疑似水军操作的营销嫌疑。总体看，沃森、辉瑞、民海三品牌 90% 以上声量来自素人用户，依赖大众自传播；康希诺在 KOL（17.30%）和媒体账号（2.60%）中声量显著高于竞品，具备更强的议题设置能力，应强化“专业背书+权威传播”差异化优势，将 KOL/媒体影响力转化为可信内容资产，协同素人账号提升传播效果。

2、自身诊断：前期触达不足，但产品体验转化力强，负面风险可控

康希诺在用户决策旅程前端（认知了解阶段）声量偏低，但后端（推荐分享阶段）口碑跃升明显；负面口碑分析显示，康希诺品牌负面内容集中于流脑疫苗（非 PCV13），未出现 PCV13 舆情风险。但当前核心问题是“好产品如何被看见”。应利用低负面口碑窗口期，将产品体验优势前置化，通过真实用户证言反哺前端认知，解决产品转化问题。

3、渠道分布：小红书为核心阵地，微博呈现差异化价值

小红书凭借其母婴社区属性，各品牌在小红书声量比例 44.90%-78.40%，成为经验分享与种草首选平台。康希诺品牌在微博表现突出（30.00%），在微博的高占比与其政策关联性强、常被纳入公共卫生议题讨论密切相关，可借势热点事件扩大权威影响力形成差异化优势。抖音（15.30%-20.10%）成为潜力增长渠道，但各品牌布局同质化，尚未形成明显差距。

4、内容类型：科普与咨询为主战场，品牌在关键场景渗透力分化显著

科普知识类（40.90% - 47.60%）与咨询讨论类（33.30% - 39.40%）构成用户决策核心内容场景，但品牌表现差异明显，沃安欣、沛儿 13、维民菲宝已深度嵌入高价值决策话题；而优佩欣在科普类内容中声量仅 23.70%，存在明显短板。用户高度依赖专业信息构建认知，内容质量与场景契合度决定品牌话语权。成熟品牌通过“接种建议”“对比指南”“不良反应应对”等实用内容占据用户心智，新品牌若仅做泛科普则难以建立决策影响力。

5、负面口碑：不良反应是吐槽重点，优配欣负面口碑为 0

辉瑞负面口碑中，聚焦不良反应与价格过高，进口品牌光环减弱，面临国产替代压力。**沃森**的负面口碑中，社媒端关注不良反应与竞品对比，媒体端聚焦财务风险与业绩下滑，品牌信任承压。**民海**的负面口碑中，集中于临床试验设计质疑与安全性担忧，新技术路线需加强科学沟通。**康希诺**负面口碑主要集中在消费者对其疫苗接种后不良反应的担忧，该负面口碑主要涉及旗下流脑疫苗（非 PCV13），在本报告采集周期内，PCV13 产品负面口碑为 0。

六、结论与建议

（一）研究结论

本报告基于对 2025 年近一年儿童家长社交媒体主贴分析，系统梳理了 PCV13 疫苗的用户决策逻辑、竞争格局及舆论生态。研究发现，尽管康希诺旗下新品优佩欣在上市初期实现了较高的认知触达，但其声量路径呈现出典型的“高认知、低转化、弱口碑”特征，尚未形成有效的用户决策闭环。与此同时，Z 世代妈妈群体正展现出日益显著的“科学化、精细化、社交化”育儿决策倾向，为具备技术优势与专业背书能力的国产创新疫苗提供了结构性机会窗口。本报告据此提出内容营销策略体系，旨在助力优佩欣突破当前增长瓶颈，在高度集中的 PCV13 市场中建立差异化品牌资产。

第一，新品困境：陷入“高认知、低转化、弱口碑”的断层陷阱。

报告数据显示，优佩欣在上市初期成功实现了较高的认知触达（“认知了解”阶段声量 60.0%），但未能有效承接用户的后续决策旅程。其声量在“信息搜集”阶段骤降至 20.0%，并在“推荐分享”阶段进一步萎缩至 35.0%，远低于竞品沃安欣（67.7%）和沛儿 13（60.1%）。这表明潜在用户在初步了解后有流失情况，未能形成自发传播的口碑闭环。

第二，核心机会：Z 世代妈妈成为关键破局点，其决策逻辑高度匹配优佩欣的创新属性。

研究发现，Z 世代妈妈不仅高度关注疫苗安全性（85.40%）与有效性（59.90%），还主动探究技术工艺（38.80%）、个体适配条件（54.20%）及费用报销政策（比例达非 Z 世代 4 倍以上），体现出强烈的“主动探索型”与“收益导向型”特征。她们倾向于通过专业信息验证价值，而非依赖品牌惯性，这为具备真实技术优势的国产创新疫苗提供了打破进口依赖、建立新信任锚点的战略契机。

第三，独特优势：康希诺拥有强大的专业势能，但尚未有效下沉至用户端。

作为企业品牌，康希诺在 KOL（17.30%）与媒体（2.60%）端的声量占比显著高于其他竞品，且在微博平台声量占比达 30.00%，反映出其在医生、专家、政务等权威节点中的高渗透率。然而，这些专业势能目前多停留在议程设置层面，未能下沉为通俗易懂、场景化的用户内容，导致“专家认可”与“大众选择”之间存在转化鸿沟。

第四，市场空白：内容同质化严重，深度说服与个性化沟通存在巨大空间。

尽管沃安欣与沛儿 13 这两个产品声量主导舆论场，但其社媒内容多集中于基础科普与经验分享，缺乏对技术细节、个体适配、长期健康规划等高阶决策要素的深度回应。市场在“广度覆盖”上趋于饱和，但在“深度说服”上仍存空白，为优佩欣以“科学决策支持者”身份切入提供了差异化突破口。

（二）对策建议

以优佩欣®（PCV13）作为康希诺婴幼儿免疫布局的战略支点，系统串联公司在肺炎、流脑、百白破及 mRNA 平台等方向的创新管线，**逐步构建覆盖从 2 月龄婴幼儿到成人的全生命周期重大传染病免疫解决方案**，推动公司从“单品领先”向“综合免疫方案领导者”升级，持续强化康希诺“以创新技术守护生命健康”的专业品牌形象。

同时，结合新产品上市节奏，本报告建议采取以下分阶段、有重点的内容营销与媒介渠道策略。

1、第一阶段：上市引爆期—— 聚焦“科学信任”，解决“为什么选我”

（1）**核心目标**：利用康希诺的专业势能，快速建立优佩欣的科学可信形象，承接高认知流量。

（2）内容主题建议：

- ◆ “优佩欣 vs 进口/国产竞品”对比指南： 针对 Z 世代妈妈的比较需求，制作结构化、数据化的对比内容。重点突出优佩欣在血清型覆盖（尤其针对国内流行株）、不良反应率、接种程序便利性等方面的差异化优势。避免贬低竞品，强调客观数据。
- ◆ “技术解码”系列： 将复杂的生产工艺、技术原理转化为可视化、故事化的内容。例如，用动画解释“载体技术如何工作”，用图表展示“临床试验数据解读”。内容需附带信息来源（如说明书、临床试验编号），提升可信度。
- ◆ “医生/专家说”轻量化内容： 与儿科医生、疫苗科普 KOL 合作，制作 15-60 秒的短视频或图文笔记，直接回答用户高频问题（如“优佩欣适合我家宝宝吗？”、“打完会发烧吗？”）。采用“共情+解答”模式，弱化说教感。

(3) 媒介渠道策略：

- ◆ 小红书：作为核心种草阵地，投放上述所有类型内容。重点合作母婴垂类 KOC（素人意见领袖），鼓励她们发布真实的“选择理由清单”和“决策过程记录”。
- ◆ 微博：利用其政策关联性强的优势，结合公共卫生热点事件（如肺炎高发季），发布由媒体/KOL 背书的权威科普长文或话题，强化品牌的公信力。
- ◆ 抖音：制作快节奏、强视觉冲击的科普短视频，重点传递核心卖点（如“覆盖 XX 种肺炎球菌”、“不良反应率低至 X%”），用于广泛触达和初步认知建立。

2、第二阶段：转化深耕期—— 聚焦“体验闭环”，解决“用了怎么样”

(1) 核心目标： 激发早期用户的 UGC（用户生成内容），将产品体验优势前置化，形成可复制、可参考的社交证据链，打通从“被看见”到“被选择”的转化路径。

(2) 内容主题建议：

- ◆ “真实接种日记”模板化引导：为已接种用户提供标准化的记录模板，如“我的优佩欣接种 Day1-3 观察表”（记录体温、睡眠、饮食、局部反应等）。鼓励用户分享细节化、非广告式的体验，如“Day2：宝宝有点烦躁，但没发烧，医生说正常”。
- ◆ “Q&A 实录”合集：系统收集并整理用户在评论区、私信中的真实疑问，由官方账号或合作医生定期发布“有问必答”合集，展现品牌的响应速度与专业态度。
- ◆ “个性化决策工具”：开发轻量级 H5 小程序，嵌入社媒内容中。用户输入孩子年龄、健康状况（如是否有湿疹）、所在城市等信息，即可自动生成“是否适合接种优佩欣”、“预计自费金额”、“附近可接种门诊”等个性化结果。

(3) 媒介渠道策略：

- ◆ 小红书 & 抖音：主战场。通过话题运营（如#优佩欣真实记录#、#我的肺炎疫苗选择#）聚合 UGC 内容，并给予优质内容流量扶持。在评论区主动置顶常见问题的标准化解答，并附上“接种门诊查询”等实用链接。

- ◆ 知乎：针对高知、深度研究型用户，开设“优佩欣家长关心的 10 个问题”专栏，由合作医生以第一人称口吻进行系统、专业的解答，建立深度信任。

3、第三阶段：口碑巩固期—— 聚焦“精准触达”，实现长效增长

（1）**核心目标：**巩固在 Z 世代妈妈群体中的口碑，并向更广泛的用户圈层渗透。

（2）**内容主题建议：**

- ◆ “长期健康规划”视角：将优佩欣纳入儿童整体健康管理方案中，强调其在预防肺炎、降低住院风险等方面的长期价值，契合 Z 世代妈妈“长期健康规划意识”强的特点。
- ◆ “二胎家庭”证言：挖掘二胎家庭的推荐分享内容。报告显示，二胎家庭的“推荐分享”意愿高达 76.1%。他们的经验分享更具说服力，是影响头胎家庭的关键节点。

（3）**媒介渠道策略：**

- ◆ 全域协同：在小红书、抖音、微博形成内容矩阵，小红书主攻深度种草与口碑沉淀，抖音主攻广泛触达与快速转化，微博主权威发声与热点借势。
- ◆ 线下联动：推动社区医院、儿科门诊提供标准化的优佩欣咨询物料（如对比手册、FAQ 卡片），确保线上线下信息一致性，降低用户的验证成本，完成最终的信任转化。

附录：“用户画像”+“用户决策旅程”标签体系（四级标签）

一级标签	二级标签	三级标签	四级标签
A 用户画像	A12. 消费理念	A121. 家庭经济状况	A1211. 宽裕稳定型
			A1212. 收支平衡型
			A1213. 预算紧缩型
		A122. 消费价值取向	A1221. 价格驱动型
			A1222. 品牌信赖型
			A1223. 功能导向型
		A123. 品牌偏好	A1231. 国产
			A1232. 进口
	A11. 育儿理念	A111. 科学导向	A1111. 科学育儿生理层面
			A1112. 科学育儿心理层面
		A112. 风险导向	A1121. 风险认同
			A1122. 风险厌恶
			A1123. 平常心看待
	A13. 儿童健康认知	A131. 长期健康规划意识	
		A132. 预防优于治疗观念	
	A14. 儿童疾病认知	A141. 疾病认知-脑膜炎	
		A142. 疾病认知-肺炎	
		A143. 疾病认知-百白破	
	A15. 自费疫苗认知及接受程度	A151. 科学决策型	
		A152. 社媒驱动型	
		A153. 价值权衡型	
		A154. 便捷优先型	
		A155. 焦虑观望型	
	A2. 地域	城市分布	
	A3. 儿童周期（年龄）	A31. 孕期	
		A32. 6周-3月龄	
		A33. 7~11月龄	
		A34. 12-23月龄	
		A35. 2-5岁	
		A36. 头胎	
		A37. 二胎	
B 用户决策旅程	B1. 认知了解	B11. 疾病认知	B111. 疾病症状认知
			B112. 严重性认知
		B12. PCV13 疫苗认知	B121. 疫苗保护范围认知
			B122. 疫苗安全性认知
			B123. 疫苗误区认知
		B13. 接种政策认知	B131. 免疫规划状态认知
			B132. 费用政策认知
			B133. 接种地点政策认知
	B2. 信息搜集	B21. 线上渠道	

	B22. 线下渠道	
B3. 对比决策	B31. 疫苗属性因素	B311. 安全性因素
		B312. 有效性因素
		B313. 技术工艺因素
		B314. 品牌信任因素
	B32 接种经济成本因素	
	B33. 接种便利性因素	
	B34. 风险收益因素	B341. 接种收益因素
		B342. 不良反应风险因素
B4. 推荐分享	B35. 孩子自身因素	B351. 年龄阶段因素
		B352. 健康状况因素
	B41. 疫苗接种攻略	
	B42. 疫苗接种体验	
	B43. 疫苗接种后反应	
	B44. 疫苗选择建议	
	B45. 疫苗接种注意事项	